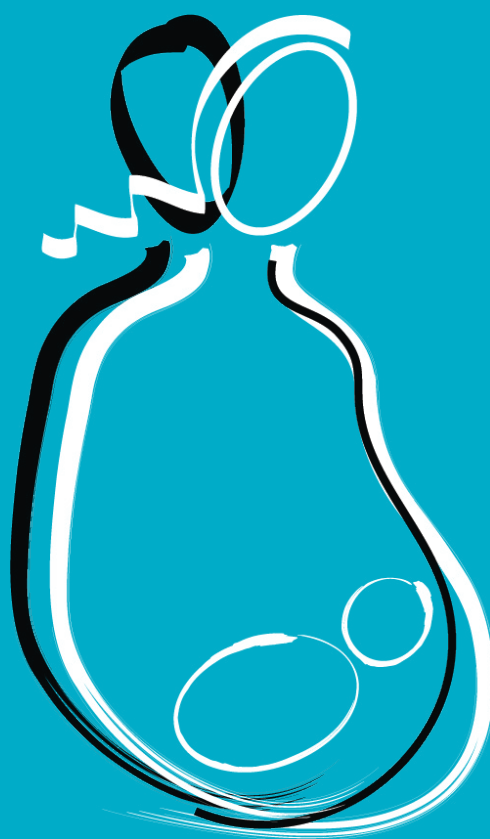


Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS

MANUEL D'UTILISATION



Organisation
mondiale de la Santé

human
reproduction
programme **hrp.**
research for impact
UNDP · UNFPA · UNICEF · WHO · WORLD BANK

Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS

Manuel d'utilisation



**Organisation
mondiale de la Santé**

human
reproduction
programme **hrp.**
research for impact
UNDP · UNFPA · UNICEF · WHO · WORLD BANK

Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS : manuel d'utilisation [WHO labour care guide: user's manual]

ISBN 978-92-4-002851-7 (version électronique)

ISBN 978-92-4-002852-4 (version imprimée)

© **Organisation mondiale de la Santé 2021**

Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'oeuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'oeuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci-dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'oeuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation de l'emblème de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette oeuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle oeuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette oeuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>).

Citation suggérée. Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS : manuel d'utilisation [WHO labour care guide: user's manual]. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2021. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <http://apps.who.int/iris>.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <http://apps.who.int/bookorders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir www.who.int/about/who-we-are/publishing-policies/copyright.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente oeuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente oeuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Table des matières

Remerciements	v
Acronymes et abréviations	vi
Introduction	1
Objectif du présent manuel	2
Public visé	2
Guide de gestion du travail d'accouchement	2
Pour qui le Guide de gestion doit-il être utilisé ?	2
Quand faut-il commencer à utiliser le Guide de gestion du travail d'accouchement ?	3
Où le Guide de gestion du travail d'accouchement doit-il être utilisé ?	3
Structure du Guide de gestion du travail d'accouchement	3
Comment utiliser le Guide de gestion du travail d'accouchement	5
De la surveillance du travail d'accouchement à l'action	5
Utilisation du Guide de gestion du travail d'accouchement	6
Nomenclature pour remplir le Guide de gestion du travail d'accouchement	7
Comment remplir la section 1 : Identification des informations et des caractéristiques du travail d'accouchement lors de l'admission	8
Comment remplir la section 2 : Soins de soutien	10
Comment remplir la section 3 : Soins du bébé	12
Comment remplir la section 4 : Soins de la femme	15
Comment remplir la section 5 : Progression du travail d'accouchement	18
Comment remplir la section 6 : Médicaments	22
Comment remplir la section 7 : Prise de décision consensuelle	23
Références bibliographiques	25
Annexe 1 : Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS	26
Annexe 2 : Adaptation du Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS	27
Annexe 3 : Introduction du Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS dans les services de maternité	28
Annexe 4 : Liste récapitulative des recommandations sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l'accouchement	30
Annexe 5 : Matériel et fournitures de base pour les soins intrapartum	36

Remerciements

Le Département Santé sexuelle et reproductive, et recherche et le Département Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, et vieillissement de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) remercient les nombreuses personnes et organisations qui ont contribué à l'élaboration du présent manuel.

Fernando Althabe, Mercedes Bonet et Olufemi Oladapo, du Département Santé sexuelle et reproductive, et recherche, sont à l'initiative et ont coordonné les travaux sur le présent manuel. Les membres du personnel du Siège de l'OMS ci-après ont contribué à l'élaboration du manuel à différentes étapes : Maurice Bucagu, Frances McConville et Anayda Portela.

L'OMS remercie sincèrement Richard Adanu, Stine Bernitz, Blami Dao, Soo Downe, Justus Hofmeyr, Caroline Homer, Vanora Hundley, Barbara Levy, Tina Lavender, David Lissauer, Robert Pattinson, João Paulo Souza, Mary Ellen Stanton, Jeff Stringer, Petra ten Hoopen-Bender et Valerie Vannevel, membres du groupe de travail technique.

Nous apprécions les commentaires formulés par un grand nombre d'acteurs internationaux à l'occasion des phases d'enquête et d'évaluation qui ont eu lieu dans le cadre de l'élaboration de ce manuel. Nous remercions tout particulièrement tous les partenaires de recherche pour les contributions qu'ils ont apportées dans le cadre d'une évaluation multipays du Guide de gestion du travail d'accouchement, coordonnée par Joshua Vogel et Veronica Pingray. Veronica Pingray a coordonné l'enquête internationale menée aux fins de l'établissement de la version originale du Guide de gestion du travail d'accouchement, a rédigé la première version du manuel, et a coordonné les contributions des parties prenantes.

Le financement de ce manuel a été assuré par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP), un programme coparrainé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Banque mondiale et exécuté par l'OMS. Les points de vue des organismes de financement n'ont pas influencé le contenu du présent manuel.

Acronymes et abréviations

bpm	battements par minute
FNUAP	Fonds des Nations Unies pour la population
HPP	hémorragie du post-partum
IM	injection intramusculaire
IV	voie intraveineuse
OMS	Organisation mondiale de la Santé
RCF	rythme cardiaque fœtal
TAD	tension artérielle diastolique
TAS	tension artérielle systolique
TCC	traction contrôlée du cordon
UI	unité internationale
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance
USAID	Agence des États-Unis pour le développement international

Introduction

Plus d'un tiers des décès maternels, de la moitié des mortinaissances et d'un quart des décès néonataux sont dus à des complications au cours du travail et de l'accouchement (1,2). La majorité de ces décès surviennent dans des milieux où les ressources sont limitées, et sont en grande partie évitables si l'on intervient à temps (3). Afin d'éviter les issues défavorables au moment de la naissance, il est indispensable d'effectuer une surveillance du travail et de l'accouchement, de détecter et de traiter rapidement toute complication. Il est prouvé que l'amélioration de la qualité des soins apportés pendant la période qui entoure la naissance est plus efficace pour réduire les mortinaissances et les décès maternels et néonataux, que les stratégies qui reposent sur les soins prénatals ou postnatals (4).

En février 2018, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié un ensemble de recommandations sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l'accouchement (5). Les recommandations comprennent de nouvelles définitions de la durée du premier et du deuxième stades du travail et fournissent des conseils indiquant comment et quand il faut intervenir pendant le travail afin d'améliorer la santé et le bien-être des femmes et de leurs bébés (5-7). Les recommandations sont fondées sur le principe qu'en utilisant des pratiques efficaces pendant le travail et l'accouchement et en évitant les pratiques inefficaces (et potentiellement néfastes), le personnel de santé peut aider les femmes à atteindre l'état physique, émotionnel et psychologique souhaité pour elles-mêmes, leurs bébés et leurs familles (8).

Les recommandations de l'OMS sur les soins intrapartum indiquent quelles pratiques fondées sur des éléments factuels devraient être mises en œuvre tout au long du travail et immédiatement après l'accouchement, et découragent les pratiques inefficaces qui devraient être évitées. Elles couvrent les sujets suivants :

- soins au cours du travail et de l'accouchement: soins maternels respectueux, communication effective, accompagnement durant le travail et continuité des soins ;
- premier stade du travail : définitions de la phase de latence et de la phase active du travail, durée et progression du premier stade du travail, politique d'admission en salle de travail, examen clinique du bassin à l'admission, examen de routine du bien-être du fœtus lors de l'admission pour la prise en charge du travail, rasage du pubis, lavement à l'admission, toucher vaginal, préparation vaginale, cardiotocographie continue, auscultation intermittente du rythme cardiaque fœtal, soulagement de la douleur, liquides et nourriture par voie orale, mobilité et position maternelle, gestion active du travail, amniotomie de routine, utilisation d'ocytocine pour prévenir le travail prolongé, antispasmodiques et administration de liquides intraveineux pour prévenir le travail prolongé ;
- deuxième stade du travail : définition et durée du deuxième stade du travail, position d'accouchement (avec ou sans analgésie péridurale), méthode de poussée, techniques de prévention des traumatismes périnéaux, épisiotomie et expression abdominale ;
- troisième stade du travail : administration prophylactique d'utérotoniques, clampage tardif du cordon ombilical, traction contrôlée du cordon (TCC) et massage utérin ;
- soins au nouveau-né : aspiration systématique de la bouche et du nez, contact peau-à-peau, allaitement maternel, prophylaxie de la maladie hémorragique par la vitamine K, bain et autres soins postnatals immédiats du nouveau-né ;
- soins à la femme après l'accouchement : surveillance de la tonicité utérine, utilisation d'antibiotiques, surveillance maternelle post-partum de routine et sortie de l'hôpital après une naissance vaginale sans complications.

Afin de faciliter l'application effective des recommandations susmentionnées, l'OMS a examiné et révisé le format du partogramme précédent. Le Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS a été conçu de façon à permettre au personnel de santé de surveiller le bien-être des femmes et des bébés pendant le travail au moyen d'évaluations

régulières visant à détecter tout paramètre s'écartant de la normalité. Cet outil vise à stimuler la prise de décisions partagées par les prestataires de soins de santé et les femmes, et de promouvoir des soins centrés sur ces dernières. Il doit être vu comme une ressource contribuant à garantir des soins de qualité fondés sur des données probantes, en mettant particulièrement l'accent sur la sécurité, la prévention des interventions inutiles et la prestation de soins de soutien.

Objectif du présent manuel

Le présent manuel a été élaboré afin d'aider le personnel de santé qui s'occupe des femmes pendant le travail et l'accouchement à utiliser correctement le Guide de gestion du travail d'accouchement.

Public visé

Le principal public visé par le présent manuel comprend le personnel de santé qualifié fournissant directement des soins pendant le travail et l'accouchement, dans tous les milieux. Cela comprend les sages-femmes, les infirmiers, les médecins généralistes et les obstétriciens. Ce manuel présente également un intérêt pour les formateurs, les administrateurs d'établissements de santé et les administrateurs de programmes de santé maternelle et infantile, les organisations non gouvernementales, et les sociétés professionnelles impliquées dans la planification et la gestion des services de santé maternelle et infantile.

Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS

Les principaux objectifs du Guide de gestion du travail d'accouchement sont les suivants :

- guider le suivi du bien-être des femmes et des bébés et de la progression du travail, ainsi que sur l'enregistrement des informations à ces sujets ;
- aider le personnel de santé qualifié à offrir des soins de soutien tout au long du travail afin que les femmes aient une expérience positive de l'accouchement ;
- aider le personnel de santé qualifié à détecter et à traiter rapidement les complications liées au travail, en fournissant des seuils de référence pour les données à surveiller pendant le travail afin que le personnel soit alerté et prenne les mesures qui s'imposent si des observations anormales sont enregistrées ;
- prévenir les interventions inutiles pendant le travail et l'accouchement ;
- faciliter l'audit et l'amélioration de la qualité de la prise en charge du travail

Pour qui le Guide de gestion du travail d'accouchement doit-il être utilisé ?

Le Guide de gestion du travail d'accouchement a été conçu pour la prise en charge des femmes et des leurs bébés pendant le travail et l'accouchement. Il comprend des évaluations et des observations essentielles à l'offre de soins à toutes les femmes enceintes, quel que soit leur niveau de risque. Toutefois, il a été principalement conçu pour être utilisé pour les soins aux femmes enceintes à priori en bonne santé (c'est-à-dire les femmes ayant des grossesses à faible risque) et leurs bébés. Les femmes ayant un risque élevé de complications pendant le travail peuvent nécessiter d'une surveillance et des soins spécialisés supplémentaires (9).

À leur arrivée à la maternité, les femmes doivent subir un examen initial pour déterminer si le travail d'accouchement a commencé. Des conseils détaillés sur la façon d'effectuer un examen initial pour évaluer le bien-être de la femme et de son bébé et déterminer le stade dans laquelle se trouve le figurent dans la publication *Pregnancy, Childbirth, Postpartum and*

Newborn Care: a guide for essential practice, 3rd ed. (10). Si le travail a commencé, les femmes nécessiteront une surveillance plus poussée de la progression du travail à l'aide du Guide de gestion du travail d'accouchement.

Quand faut-il commencer à utiliser le Guide de gestion du travail d'accouchement ?

La collecte d'informations sur le bien-être de la femme et de son bébé ainsi que sur la progression du travail au moyen du Guide de gestion du travail d'accouchement doit commencer lorsque la femme entre dans la phase active du premier stade du travail (dilatation du col de 5 cm ou plus), quelque soit sa parité, et indépendamment de l'état des membranes.

Bien que le Guide de gestion du travail d'accouchement ne doive pas être utilisé pendant la phase de latence du travail, les femmes et leurs bébés doivent tout de même être surveillés et recevoir des soins et du soutien durant cette période. Des orientations détaillées sur les soins aux femmes en phase de latence du travail figurent dans la publication *Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: a guide for essential practice*, 3rd ed. (10).

Où le Guide de gestion du travail d'accouchement doit-il être utilisé ?

Le Guide de gestion du travail d'accouchement a été conçu pour être utilisé pour toutes les naissances dans les établissements de santé, y compris les établissements de soins de premier niveau, secondaires et tertiaires. Les femmes qui accouchent dans des établissements de niveau inférieur peuvent avoir besoin d'être transférées vers un établissement de niveau plus élevé en cas de complications. Elles doivent donc avoir la possibilité de se rendre dans un établissement approprié et avoir accès à des moyens de transport pour être transférées en toute sécurité et en temps opportun. L'utilisation du Guide de gestion du travail d'accouchement peut faciliter l'identification précoce des complications potentielles ; par conséquent, il devrait faciliter les transferts en temps opportun le cas échéant.

Encadré 1: Résumé des éléments à retenir pour commencer à utiliser le Guide de gestion du travail d'accouchement

Pour qui le Guide de gestion du travail d'accouchement doit-il être utilisé ?

Toutes les femmes en travail d'accouchement. Les femmes présentant un risque élevé de complications, peuvent avoir besoin d'un suivi et de soins complémentaires.

Quand dois-je commencer à utiliser le Guide de gestion du travail d'accouchement ?

Lorsque les femmes sont entrées dans la phase active du premier stade du travail (c'est-à-dire quand la dilatation du col atteint 5 cm ou plus).

Où le Guide de gestion du travail d'accouchement peut-il être mis en œuvre ?

Le Guide est conçu pour être utilisé à tous les niveaux de soins dans les établissements de santé.

Structure du Guide de gestion du travail

Le Guide de gestion du travail d'accouchement compte sept sections, qui ont été adaptées de la précédente version du partogramme. Les sections sont les suivantes (voir fig. 1) :

1. Identification des informations et des caractéristiques du travail lors de l'admission
2. Soins de soutien
3. Soins du bébé
4. Soins de la femme
5. Progression du travail
6. Médicaments
7. Prise de décision partagée

Figure 1. Sections du Guide de gestion du travail d'accouchement

GUIDE DE GESTION DU TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT DE L'OMS																																															
Section 1		Nom		Parité		Début du travail		Diagnostic de la phase active [Date]																																							
		Rupture de membranes [Date]		Heure		Facteurs de risque																																									
Section 2		Colonne de référence		<table border="1"> <tr> <th>Heure</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th> </tr> <tr> <th>Nb d'heures</th> <td colspan="15"></td> </tr> </table>												Heure	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	Nb d'heures															
				Heure	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																												
Nb d'heures																																															
		ALERTE		PREMIERE PHASE ACTIVE										DEUXIEME STADE																																	
Section 2		SOINS DE SOUTIEN		Accompagnant(e)	N																																										
				Anti douleur	N																																										
				Liquides per os	N																																										
				Posture	DD																																										
Section 3		BEBE		RCP de Base	<110, ≥160																																										
				Ralentissement du RCF	TD																																										
				Liquide amniotique	M+++ , S																																										
				Présentation	P, T																																										
				Bosse séro sanguine	+++																																										
				Modelage de la tête	+++																																										
Section 4		FEMME		Pouls	<60, ≥120																																										
				TA systolique	<80, ≥140																																										
				TA diastolique	≥90																																										
				Température °C	<35,0; ≥ 37,5																																										
				Urines	P++, A++																																										
Section 5		PROGRESSION DU TRAVAIL		Contractions par 10 min	≥2, >5																																										
				Durée des contractions	<20, >60																																										
				Dilatation du col [Noter X]	10																																										
					9	≥ 2h																																									
					8	≥ 2.5h																																									
					7	≥ 3h																																									
					6	≥ 5h																																									
				Descente [Noter O]	5	≥ 6h																																									
					4																																										
					3																																										
2																																															
1																																															
Section 6		MEDICAMENTS		Ocytocine (U/L, gouttes/min)																																											
				Médicament																																											
				Liquides IV																																											
Section 7		PRISE DE DECISION PARTAGEE		EVALUATION																																											
				PLAN DE SOINS																																											
		INITIALES DU PRESTATAIRE																																													

INSTRUCTIONS : ENCERCLER TOUTE OBSERVATION QUI REpond AUX CRITERES DANS LA COLONNE 'ALERTE'. ALERTER LA SAGE FEMME SENIOR OU LE MEDECIN ET NOTER L'EVALUATION FAITE ET L'ACTION DECIDEE. SI LE TRAVAIL SE PROLONGE AU-DELA DE 12H, VEUILLEZ CONTINUER SUR UN NOUVEAU GUIDE DE GESTION DU TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT.

Abbreviations: O – Oui, N – Non, R – Refusé, In – Inconnu, DD – Décubitus Dorsal, EM – En Mouvement, Pr – Précoce, TD – Tardif, V – Variable, I – Intact, C – Clair, M – Méconium, S – Sanguinolent, A – Antérieur, P – Postérieur, T – Transverse, P+ – Protéines, A+ – Acétones

La section 1 sert à renseigner le nom de la femme et les principales caractéristiques du travail au moment de l'admission : parité, mode de début du travail, date du début de la phase active, date et heure de rupture des membranes et facteurs de risque. Cette section doit être remplie au moyen des informations obtenues lorsque le diagnostic de la phase active du travail est confirmé.

Les sections 2 à 7 servent à enregistrer des observations au cours du travail. Le personnel de santé doit remplir ces sections une fois que la femme est admise en salle de travail. Le reste du Guide de gestion du travail d'accouchement est ensuite complété à la suite d'évaluations effectuées tout au long du travail. Pour toutes les observations, il existe un axe de temps horizontal pour indiquer l'heure à laquelle les données sont observées et un axe vertical de valeurs de référence pour repérer tout écart par rapport aux observations normales. Le Guide de gestion du travail d'accouchement comporte également une section sur le deuxième stade du travail, qui permet de consigner les mêmes données que pendant le premier stade (à l'exception de l'évaluation de la dilatation du col, qui se termine au premier stade du travail).

Comment utiliser le Guide de gestion du travail d'accouchement

De la surveillance du travail d'accouchement à l'action

Des évaluations régulières des événements durant le travail sont nécessaires pour veiller au bien-être des femmes et de leurs bébés. Pendant ces évaluations, la décision d'intervenir au cours du travail est principalement fondée sur l'observation d'un écart par rapport aux données attendues.

Afin de faciliter la surveillance du travail axée sur l'action, le Guide de gestion du travail d'accouchement fournit des valeurs de référence explicites et comprend une section pour consigner les décisions consensuelles prises pour remédier à tout écart par rapport à la norme. En vue de veiller à l'application systématique et cohérente du Guide de gestion du travail d'accouchement, les prestataires de soins sont encouragés à utiliser l'approche « évaluation, enregistrement, vérification, planification », qui consiste à :

- **évaluer** le bien-être de la femme et de son bébé et la progression du travail ;
- **enregistrer** les données d'observation concernant le travail ;
- **vérifier** ces données en les comparant aux valeurs de référence dans la colonne « Alerte » ;
- **planifier** en décidant s'il faut intervenir et, le cas échéant, de quelle manière, en consultation avec la femme, et consigner la décision prise.

Il est primordial que les prestataires de soins surveillent de façon prospective le bien-être des femmes et des bébés et la progression du travail, et appliquent l'approche ci-dessus à chaque évaluation effectuée pendant le travail et l'accouchement.

Les sections ci-dessous fournissent des indications à l'intention des soignants sur la façon de remplir chaque section du Guide de gestion du travail. Un exemple clinique est donné à chaque fois afin d'illustrer l'utilisation du Guide.

Le Guide de gestion du travail d'accouchement a été conçu à titre indicatif et ne se substitue pas à un bon jugement clinique, avec respect de la situation et des préférences individuelles des femmes.

Des orientations complémentaires sur la prise en charge clinique des femmes pendant le travail et l'accouchement, y compris la prise en charge des complications, figurent dans les publications *Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: a guide for essential practice*, 3rd ed. (10) et *Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors*, 2nd ed. (9).

Pour des raisons pratiques, les observations concernant les femmes et celles concernant les bébés sont ici présentées séparément. Toutefois, les décisions ne doivent pas être fondées sur les constatations tirées d'observations individuelles, mais plutôt sur une évaluation globale de la femme et de son bébé.

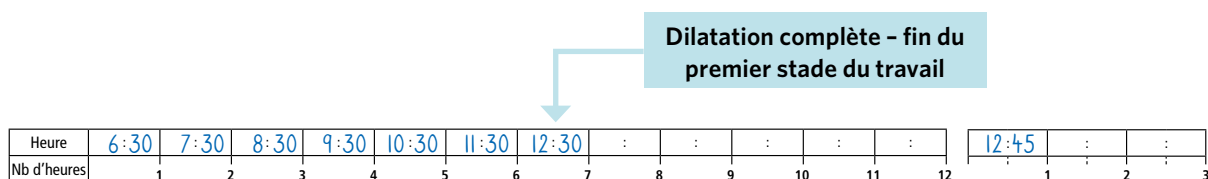
Utilisation du Guide de gestion du travail d'accouchement

Axe de temps : La première ligne de l'axe de temps (« Heure ») sert à enregistrer l'heure pour chaque observation, tandis que la deuxième ligne (« Nb d'heures ») indique le nombre d'heures qui se sont écoulées au cours du travail (voir fig. 2). La ligne « Temps » est divisée en colonnes pour enregistrer le temps réel en heures et minutes. Chaque colonne représente une heure d'horloge.

Comme décrit dans l'exemple ci-dessous, si la première évaluation est effectuée à 6 h 30 et que les deuxième et troisième évaluations sont effectuées respectivement 1 et 2 heures plus tard, à 7 h 30 et à 8 h 30, elles doivent toutes être consignées dans les colonnes correspondantes. Si à 12 h 30 la dilatation du col est complète, il faut continuer de consigner l'heure dans les cases du deuxième stade du travail.

Si le travail s'étend au-delà de 12 heures, il faut continuer sur un deuxième Guide. L'heure doit être enregistrée au moyen du système horaire sur 12 ou 24 heures, selon la pratique locale.

Figure 2. Indication de l'heure sur le Guide de gestion du travail d'accouchement



Colonne de référence (« Alerte ») : La colonne « Alerte » présente des seuils qui permettent de détecter les observations anormales nécessitant une évaluation plus poussée et une intervention de la part du prestataire de soins, comme le résument les tableaux 3 à 7. Si les observations sur le travail ne correspondent à aucun des critères de la colonne « Alerte », la progression et la gestion du travail doivent être considérées comme normales, et aucune intervention médicale n'est requise.

Les prestataires de soins doivent entourer toute observation répondant aux critères de la colonne « Alerte ». Cela aide à mettre en évidence les observations qui nécessitent une attention particulière.

Bien que les seuils de référence soient en grande partie fondés sur les directives de l'OMS, quelques-uns ont été établis à partir d'un consensus d'experts. Il importe de noter que les seuils de référence servent de premiers signaux d'alerte et non à diagnostiquer des complications spécifiques. Par conséquent, les valeurs de référence doivent être adaptées conformément aux lignes directrices locales et ne doivent pas remplacer le jugement clinique expert d'un prestataire de soins.

Fréquence de l'évaluation : La fréquence des observations est semblable à celle du partogramme précédent ; des indications à ce sujet figurent dans les tableaux 4 à 7. Bien que la fréquence de l'évaluation dans le Guide de gestion du travail d'accouchement soit largement fondée sur les directives de l'OMS, elle s'appuie également pour certains paramètres sur un consensus d'experts plutôt que sur des données probantes de haute qualité. Il est important que le personnel de santé adapte la fréquence du suivi à chaque cas clinique et conformément aux lignes directrices locales. La fréquence requise de l'évaluation devrait dépendre des résultats des observations faites pendant le travail et de la situation de la femme et de son enfant.

Nomenclature pour remplir le Guide de gestion du travail d'accouchement

Lorsqu'une mesure est d'ordre numérique, il faut noter les nombres réels. Aux fins de l'enregistrement d'observations non numériques ou cliniques – c'est-à-dire des observations non fondées sur le comptage – une liste d'abréviations est fournie de manière à ce que les données soient présentées de façon normalisée par les équipes soignantes. Cette liste devrait également faciliter les comparaisons avec les abréviations de la colonne « Alerte » (voir tableau 1).

Tableau 1. Abréviations pour l'enregistrement d'observations non numériques

Section 1: Identification des informations et des caractéristiques du travail lors de l'admission	
Rupture des membranes (date et heure)	In = Inconnu
Section 2: Soins de soutien	
Accompagnant(e)	O = Oui
	N = Non
	R = Refusé par la femme
Soulagement de la douleur	O = Oui
	N = Non
	R = La femme refuse de recevoir des médicaments ou des techniques non-pharmacologiques pour soulager la douleur
Liquides per os	O = Oui
	N = Non
	R = Refusé par la femme
Posture	DD = Décubitus dorsal
	EM = En mouvement
Section 3: Bébé	
Ralentissement du rythme cardiaque fœtal (RCF)	N = Non
	Pr = Précocité
	TD = Tardif
	V = Variable
Liquide amniotique	I = Membranes intactes
	C = Membranes rompues, liquide clair
	M = Présence de méconium dans le liquide : indiquer respectivement +, ++ et +++ en cas de quantité négligeable, moyenne ou méconium épais.
	S = liquide teinté de sang
Position	A = Toute position occipito-antérieure
	P = Toute position occipito-postérieure
	T = Toute position transverse
Bosse sérosanguine	O (aucune)
	+
	++
	+++ (prononcée)

Modelage de la tête	O (aucun)
	+ (sutures apposées)
	++ (sutures qui se chevauchent mais chevauchement réductible)
	+++ (sutures qui se chevauchent mais chevauchement irréductible)
Section 4: Femme	
Urines	P - (pas de protéinurie)
	P trace (trace de protéinurie)
	P 1+
	P 2+
	P 3+
Acétone	A - (pas d'acétonurie)
	A 1+
	A 2+
	A 3+
	A 4+
Section 5: Progression du travail	
Ne s'applique pas	
Section 6: Médicaments	
Ocytocine	N = Non
	Si « Oui », UI et gouttes/min
Autres médicaments	N = Non
	Si « Oui », noter le nom, la dose et le mode d'administration des médicaments
Liquides IV	O = Oui
	N = Non
Section 7: Prise de décision partagée	
Ne s'applique pas	

Comment remplir la section 1 : Identification des informations et des caractéristiques du travail lors de l'admission

Cette section note le nom de la femme et les renseignements clés nécessaires pour déterminer les caractéristiques de base et le niveau de risque que présente la femme au moment de l'admission pour l'accouchement. D'autres caractéristiques démographiques et données sur le travail importantes, telles que l'âge de la femme, l'âge gestationnel, les résultats des tests sérologiques, le taux d'hémoglobine, le groupe sanguin et le rhésus, la cause du transfert le cas échéant et la hauteur utérine, doivent figurer dans le dossier médical de la femme.

Le tableau 2 montre la façon dont il faut évaluer les variables de cette section et de noter dans le Guide de gestion du travail d'accouchement les renseignements obtenus.

Tableau 2. Instructions pour remplir la section 1 du Guide de gestion du travail d'accouchement

Variable	Étape 1: Évaluer	Étape 2: Enregistrer
Nom	Demandez à la femme son nom complet.	■ Notez le nom complet de la femme et vérifiez qu'il correspond au nom sur son dossier médical.
Parité	Trouvez dans le dossier médical le nombre de fois où la femme a donné naissance à un bébé ayant atteint l'âge de viabilité (selon les lignes directrices locales).	■ Utilisez le système de codage local pour noter la parité : par exemple, Parité (ou P) = nombre de bébés nés (d'après la définition locale de la viabilité).
Début du travail	Le travail a-t-il commencé spontanément ou a-t-il été induit (en utilisant des moyens artificiels) ?	■ Notez « Spontané » si la femme a atteint la première phase active du travail sans aucune stimulation artificielle de début du travail (par des moyens médicamenteux ou autres). ■ Notez « Induit » si le début du travail a été stimulé artificiellement, en administrant de l'ocytocine ou des prostaglandines à la femme, en procédant à une rupture artificielle des membranes, en insérant une sonde à ballonnet dans le col de l'utérus, ou par tout autre moyen.
Diagnostic de la phase active du travail	À quelle date et à quelle heure la phase active du premier stade du travail a-t-elle été diagnostiquée ?	■ Indiquez la date de diagnostic de la phase active du travail. Utilisez le format local pour noter les dates (par exemple, jj/mm/aa, mm/jj/aa, ou jj/mm/aaaa).
Rupture des membranes	À quelle date et à quelle heure les membranes amniotiques se sont-elles rompues (si les membranes se sont rompues avant l'admission) ?	■ Notez la date et l'heure (hh : mm) auxquelles la rupture des membranes s'est produite. Ces données peuvent être communiquées par la femme ou la personne qui l'accompagne, ou elles peuvent être extraites du dossier médical si les membranes se sont rompues après l'admission mais avant de commencer à remplir le Guide de gestion du travail. ■ Utilisez le format local pour noter la date et l'heure. ■ Indiquez « In » ou « inconnu » si la rupture des membranes est confirmée et que la femme ne peut pas donner la date ou l'heure et qu'il n'y a aucune indication à ce sujet dans le dossier médical.
Facteurs de risque	Facteurs de risque	■ Facteurs de risque obstétricaux, médicaux et sociaux connus pouvant influencer les soins et l'issue éventuelle de la prise en charge du travail. Par exemple, les pathologies préexistantes (comme l'hypertension chronique), les pathologies obstétricales (comme la pré-éclampsie), l'âge avancé de la femme, la grossesse précoce, le travail prématuré et la colonisation à streptocoques du groupe B.

Exemple de la façon dont il faut remplir la section 1

Date : 07 juin 2020	Heure : 06 h 00
---------------------	-----------------

Marie, une femme enceinte à faible risque de complication obstétricale, est reçue avec des contractions utérines et a indiqué que du liquide s'écoule de son vagin depuis une heure. Son âge gestationnel est de 38 semaines.

Il s'agit de sa quatrième grossesse. Elle a déjà donné naissance à deux reprises, d'un bébé vivant et d'un bébé mort-né à terme. Elle a aussi fait une fausse couche. Elle prend du fer par voie orale pour traiter son anémie.

La sage-femme responsable de l'admission a posé toutes les questions nécessaires et proposé à Marie un examen clinique pour évaluer le bien-être du bébé et la progression du travail. Entre autres paramètres, la sage-femme a constaté que Marie a des contractions régulières (3 contractions toutes les 10 minutes), que son col était dilaté à 5 cm et que les membranes étaient rompues.

La figure 3 montre de quelle façon le Guide de gestion du travail d'accouchement serait rempli avec les informations ci-dessus.

Fig. 3. Comment remplir la section 1

GUIDE DE GESTION DU TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT DE L'OMS			
Nom Marie Martin	Parité 2	Début du travail spontané	Diagnostic de la phase active [Date 07/06/20]
Rupture de membranes [Date 07/06/20 Heure 5:00]	Facteurs de risque Antécédents de mort-né, anémie		

Comment remplir la section 2: Soins de soutien

La garantie de soins de maternité respectueux est un droit humain fondamental des femmes enceintes et une composante essentielle des recommandations de l'OMS en matière de soins intrapartum (5). L'OMS recommande également une communication efficace entre les prestataires de soins de maternité et les femmes qui accouchent, y compris l'utilisation d'un langage simple et culturellement approprié à toutes les étapes de la prise en charge du travail et l'accouchement. Des explications claires des procédures et de leur but doivent toujours être fournies à chaque femme. Les résultats des examens physiques doivent être expliqués à la femme et à la personne qui l'accompagne, et le plan d'action, déterminé par ces résultats, doit être clairement présenté afin que les décisions soient prises de façon conjointe.

Cette section du Guide de gestion du travail d'accouchement vise à encourager la pratique systématique de soins de maternité respectueux pendant le travail et l'accouchement, au moyen de la prestation et le suivi continus de soins de soutien. Cela comprend la présence d'un(e) accompagnant(e) pendant le travail, l'accès à l'analgésie ou autres techniques pour soulager la douleur, la garantie que les femmes se voient offrir du liquide par voie orale et des techniques pour améliorer le confort des femmes (comme encourager les femmes à rester en mouvement pendant le travail) (voir tableau 3). Les mesures de soutien doivent être proposées et évaluées tout au long du travail. Toutefois, pour simplifier l'enregistrement des données, les observations concernant la prestation de soins de soutien doivent être consignées uniquement toutes les heures.

Tableau 3. Instructions pour remplir la section 2 du Guide de gestion du travail d'accouchement

	Étape 1: Évaluer	Étape 2: Enregistrer	Étape 3: Vérifier les seuils de référence	Étape 4: Planifier
Accompagnant(e)	La femme est-elle accompagnée par une personne de son choix venue pour la soutenir au moment de l'évaluation ?	O = Oui N = Non R = Refusé par la femme	Alerte : N = Non	■ Si vous avez noté « Non », proposez à la femme de lui trouver un(e) accompagnant(e) de son choix. ■ Si vous avez noté « Oui » ou « Refusé par la femme », continuez de lui demander ce qu'elle préfère tout au long du travail et au moment de l'accouchement.
Soulagement de la douleur	La femme a-t-elle reçu une technique quelconque pour soulager la douleur ?	O = Oui N = Non R = La femme refuse que des mesures soient prises pour soulager sa douleur	Alerte : N = Non	■ Si vous avez noté « Non », proposez de l'analgésie ou autre technique de soulagement de la douleur en fonction des préférences de la femme, des moyens disponibles et de l'expérience du prestataire de soins. ■ Vous pouvez proposer une péridurale utilisant la concentration efficace la plus faible d'un anesthésique local pour éviter des complications, ou des opioïdes tels que le fentanyl, la diamorphine et la péthidine. Des techniques de relaxation, incluant la relaxation musculaire, la respiration, la musique, la pleine conscience et les techniques manuelles, peuvent également être proposées, en fonction des préférences de la femme.
Liquides per os	La femme a-t-elle pris des liquides par voie orale à sa demande depuis sa dernière évaluation ?	O = Oui N = Non R = Refusé par la femme	Alerte : N = Non	■ Si vous avez noté « Non », encouragez la femme à manger léger et à boire comme elle le souhaite pendant le travail.
Posture	Quelle position la femme adopte-t-elle pendant le travail et l'accouchement ?	DD = Décubitus dorsal EM = En mouvement (comprend la marche, le balancement ou toute position autre qu'allongée sur le dos, par exemple allongée sur le côté gauche, accroupie, agenouillée, debout)	Alerte : DD = Décubitus dorsal	■ Si vous avez noté « DD », encouragez la femme à se déplacer librement pendant le premier stade du travail. ■ Soutenez le choix de position fait par la femme (allongée sur la côté gauche, accroupie, agenouillée, debout soutenue par la personne qui l'accompagne) pour chaque stade du travail.

Exemple de la façon dont il faut remplir la section 2

Date : 07 juin 2020

Heure : 06 h 00

Marie a subi une évaluation générale et clinique et a été admise en salle de travail.

Elle est suivie par la sage-femme de service, mais elle n'est pas accompagnée d'un parent ou d'une personne de son entourage.

Elle dit ressentir une forte douleur due aux contractions utérines et demande un traitement contre la douleur.

Elle a bu un jus de fruits et est en train de marcher.

Heure : 07 h 00

La sage-femme qui s'occupe de Marie pendant le travail lui a proposé de choisir son accompagnant(e). Marie voulait être accompagnée par sa sœur. La sage-femme a indiqué à la sœur de Marie quand demander de l'aide et de quelle façon.

Étant donné qu'une autre femme était en travail dans la même pièce, la sage-femme a placé un paravent entre les lits pour offrir plus d'intimité.

Marie est maintenant avec sa sœur et reçoit des instructions sur les techniques de relaxation permettant de soulager la douleur.

Elle boit de l'eau lorsqu'elle a soif et est maintenant couchée dans son lit en décubitus dorsal.

La figure 4 montre de quelle façon le Guide de gestion du travail d'accouchement serait rempli au moyen des informations ci-dessus. Les observations entourées en rouge répondent au critère correspondant dans la colonne « Alerte ».

Notez que les soins de soutien doivent être offerts et évalués en permanence. Toutefois, aux fins de l'enregistrement des données, ces activités sont consignées toutes les heures dans l'exemple donné.

Figure 4. Comment remplir la section 2

GUIDE DE GESTION DU TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT DE L'OMS															
Nom		Marie Martin		Parité		2		Début du travail		spontané		Diagnostic de la phase active [Date 07/06/20]			
Rupture de membranes [Date 07/06/20 Heure 5:00]				Facteurs de risque		Antécédents de mort-né, anémie									
Heure		6:00		7:00											
Nb d'heures		1		2		3		4		5		6		7	
ALERTE		PREMIERE PHASE ACTIVE												DEUXIEME STADE	
SOINS DE SOUTIEN	Accompagnant(e)	N	N	0											
	Anti douleur	N	N	0											
	Liquides per os	N	0	0											
	Posture	DD	EM	DD											

Comment remplir la section 3: Soins du bébé

Cette section sert à faciliter la prise de décision tout en surveillant le bien-être du bébé. Le personnel de santé veille au bien-être du bébé en observant régulièrement le rythme cardiaque fœtal de base (RCF) et ses décélérations, et en contrôlant le liquide amniotique, la position du fœtus, le modelage de la tête et le développement éventuel d'une bosse sérosanguine (gonflement diffus du cuir chevelu) (voir tableau 4).

Tableau 4. Instructions pour remplir la section 3 du Guide de gestion du travail

	Étape 1: Évaluer	Étape 2: Enregistrer	Étape 3: Vérifier les seuils de référence	Étape 4: Planifier
RCF de base	Écoutez le RCF pendant au moins 1 minute. Faites ce contrôle pendant une contraction utérine et continuez pendant au moins 30 secondes après la contraction. Prenez le pouls de la femme pour bien distinguer le rythme cardiaque de la femme et celui du bébé.	Enregistrez le RCF de base (en nombre de battements par minute). Pendant le deuxième stade, notez la valeur la plus pertinente sur le plan clinique sur une période de 15 minutes.	Alerte: <110, ≥160 <i>L'auscultation intermittente du RCF au moyen d'un appareil à ultrasons Doppler ou d'un stéthoscope fœtal de Pinard est recommandée pour les femmes enceintes en bonne santé dont le travail a commencé (5). Un RCF très lent en l'absence des contractions ou persistant après des contractions peut être un signe de souffrance fœtale. En l'absence d'une fréquence cardiaque maternelle rapide, un RCF rapide doit également être considéré comme un signe de souffrance fœtale (9).</i>	Si le RCF est <110 ou ≥160, demandez à la femme de se tourner sur son côté gauche, puis alertez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives cliniques. Si le RCF est compris entre 110 et 159, continuez à l'évaluer toutes les 30 minutes pendant le premier stade du travail et toutes les 5 minutes pendant le deuxième stade (10).
Ralentissement du RCF	Écoutez le RCF pendant au moins 1 minute. Faites ce contrôle pendant une contraction utérine et continuez pendant au moins 30 secondes après la contraction.	Prenez note des ralentissements éventuelles en indiquant : N = Non Pr = Précoce TD = Tardif V = Variable	Alerte: T = Tardif <i>Prenez note de toute ralentissements (5). Un RCF très lent en l'absence des contractions ou persistant après des contractions peut être un signe de souffrance fœtale (9).</i>	Si des ralentissements tardifs ou un seul ralentissement prolongé sont notées, demandez à la femme de se tourner sur le côté gauche, puis effectuez une auscultation prolongée, prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives cliniques. Si aucun ralentissement n'est constaté, continuez à surveiller le RCF toutes les 30 minutes pendant le premier stade du travail et toutes les 5 minutes pendant le deuxième stade (10).
Liquide amniotique	Quel est l'état des membranes ? Y a-t-il une perte de liquide amniotique ? Si « Oui », quelle est la couleur du liquide amniotique ?	I = Membranes intactes C = Membranes rompues, liquide transparent M = Membranes rompues, présence de méconium dans le liquide : indiquez respectivement +, ++ et +++ en cas de quantité négligeable, moyenne ou méconium épais. S = Membranes rompues, traces de sang dans le liquide	Alerte: M+++ (liquide méconial épais), S = traces de sang <i>Notez l'état des membranes. Si les membranes sont rompues, notez la couleur du liquide amniotique qui s'écoule. Un liquide méconial épais exige une surveillance étroite et éventuellement une intervention pour prendre en charge la souffrance fœtale (9). Le liquide amniotique sanglant est commun en cas de décollement placentaire, de placenta praevia, de vasa praevia ou de rupture utérine (11).</i>	Si le liquide est sanglant ou épais et teinté de méconium, prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives cliniques. Si les membranes sont intactes ou rompues et que le liquide amniotique est transparent, évaluez le liquide amniotique lors du prochain examen vaginal dans 4 heures, sauf indication contraire.

	Étape 1: Évaluer	Étape 2: Enregistrer	Étape 3: Vérifier les seuils de référence	Étape 4: Planifier
Position	Effectuez un examen vaginal avec douceur en utilisant une technique aseptique pour évaluer la position fœtale, après avoir obtenu le consentement de la femme et veillé à son intimité. Ne commencez pas l'examen pendant une contraction. Évaluez en même temps tous les paramètres qui nécessitent un examen vaginal.	A = Position occipito-antérieure P = Position occipito-postérieure T = Position transverse	Alerte: P = Présentation occipito-postérieure, T = Présentation transverse <i>Au moment de la descente, la tête du fœtus tourne et se met en position occipito-antérieure dans le bassin. Si le fœtus ne passe pas d'une position transversale ou occipito-postérieure à une position occipito-antérieure, la position fœtale doit être considérée comme anormale et gérée en conséquence (9).</i>	Si le fœtus est en position occipito-postérieure ou transverse, prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives cliniques. Si le fœtus est en position occipito-antérieure, réévaluez la position pendant le prochain examen vaginal dans 4 heures, sauf indication contraire.
Bosse sérosanguine	Lors de l'examen vaginal fait pour évaluer d'autres paramètres cliniques, contrôlez la présence éventuelle d'une bosse sérosanguine (gonflement diffus du cuir chevelu).	Évaluez la bosse, de 0 (aucune) à +++ (prononcée).	Alerte: +++ <i>Contrôlez la présence d'une bosse sérosanguine ainsi que d'autres paramètres concernant la mère et le fœtus afin de veiller à leur bien-être et d'évaluer les risques de problèmes à la naissance (5). Si la bosse sérosanguine au niveau de la présentation est prononcée, elle peut être un signe de dystocie (tout comme d'autres observations anormales) (9).</i>	Si la bosse sérosanguine est de niveau +++, prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les protocoles locaux. Si la bosse est évaluée entre 0 et ++, réévaluez la situation pendant le prochain examen vaginal dans 4 heures, sauf indication contraire.
Modelage de la tête	Lorsque vous effectuez un examen vaginal pour contrôler d'autres paramètres cliniques, évaluez la forme du crâne du fœtus et le degré de chevauchement des os de la tête fœtale pendant le travail.	Évaluez le chevauchement, de 0 (aucun) à +++ (prononcé). En fonction de la situation, notez + (sutures apposées), ++ (sutures qui se chevauchent mais chevauchement réductible) ou +++ (sutures qui se chevauchent mais chevauchement irréductible).	Alerte: +++ <i>Contrôlez le modelage crânien du bébé ainsi que d'autres paramètres concernant la mère et le fœtus afin de veiller à leur bien-être et d'évaluer les risques de problèmes à la naissance (5). Un modelage crânien de niveau +++ (ainsi que d'autres observations anormales) peut être un signe de dystocie (9).</i>	Si le modelage est de niveau +++, prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les protocoles locaux. Si le modelage est évalué entre 0 et ++, ce qui est généralement normal (en particulier si le niveau ++ est atteint en fin de travail), réévaluez la situation pendant le prochain examen vaginal dans 4 heures, sauf indication contraire.

Exemple de la façon dont il faut remplir la section 3

Date : 07 juin 2020 Heure : 06 h 00

Le bébé bouge pendant l'examen et a un rythme cardiaque fœtal de 140 battements par minute (bpm) sans ralentissements.

L'examen vaginal montre que le col est dilaté à 5 cm, présentation céphalique. Il n'y a pas de bosse séro sanguine ou de modelage crânien et le fœtus se présente en position occipito-postérieure. Le liquide amniotique est clair.

Heure : 06 h 30

RCF : 136 bpm sans ralentissements

Heure : 07 h 00

RCF : 132 bpm avec ralentissements variables

Heure : 07 h 30

RCF : 148 bpm sans ralentissements. La sage-femme vérifie la serviette hygiénique de Marie et observe que le liquide amniotique est clair. Étant donné que tous les autres paramètres cliniques sont normaux et que Marie supporte bien le travail, sa sage-femme continue de contrôler le RCF toutes les 30 minutes et vérifiera le liquide amniotique lors du prochain examen vaginal.

La figure 5 montre de quelle façon le Guide de gestion du travail d'accouchement devrait être rempli au moyen des informations ci-dessus. Les observations qui répondent aux critères de la colonne « Alerte » sont entourées en rouge.

Figure 5. Comment remplir la section 3

GUIDE DE GESTION DU TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT DE L'OMS																
Nom		Marie Martin		Parité		2		Début du travail		spontané		Diagnostic de la phase active		[Date 07/06/20]		
Rupture de membranes		[Date 07/06/20 Heure 5:00]		Facteurs de risque		Antécédents de mort-né, anémie										
Heure		6:00		7:00												
Nb d'heures		1		2		3		4		5		6		7		
ALERTE		PREMIERE PHASE ACTIVE													DEUXIEME STADE	
SOINS DE SOUTIEN	Accompagnant(e)	N	(N)	0												
	Anti douleur	N	(N)	0												
	Liquides per os	N	0	0												
	Posture	DD	EM	(DD)												
BEBE	RCF de Base	<110, ≥160	(140)	(136)	(132)	(148)										
	Ralentissement du RCF	TD	N	N	V	N										
	Liquide amniotique	M+++ , S	C	C												
	Présentation	P, T	(P)													
	Bosse séro sanguine	+++	0													
	Modelage de la tête	+++	0													

Comment remplir la section 4: Soins de la femme

Cette section sert à faciliter la prise de décision dans le cadre d'un suivi cohérent à intervalles réguliers du bien-être de la femme. Le personnel soignant surveille la santé et le bien-être de la femme au moyen du Guide de gestion du travail d'accouchement en contrôlant régulièrement son pouls, sa tension artérielle, sa température et ses urines (voir tableau 5).

Tableau 5. Instructions pour remplir la section 4 du Guide de gestion du travail d'accouchement

	Étape 1: Évaluer	Étape 2: Enregistrer	Étape 3: Vérifier les seuils de référence	Étape 4: Planifier
Pouls	Prenez le pouls de la femme pendant au moins 1 minute.	Notez la valeur obtenue (en bpm).	Alerte: <60, ≥120 <i>Si le pouls de la femme s'accélère, cela peut être un signe de déshydratation, de douleur, de fièvre, de saignement ou de choc (9). Si la femme souffre de bradycardie, une série d'examen doit être effectués sur la mère (et le fœtus) afin de diagnostiquer la cause probable, qui peut être l'administration de certains médicaments, la position couchée en décubitus dorsal, la douleur, des saignements ou une maladie cardiaque (12).</i>	■ Si le pouls est <60 ou ≥120, alertez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives locales. ■ Si le pouls est ≥60 ou <120, réévaluez-le toutes les 4 heures.
TA systolique	Mesurez la tension artérielle en position assise.	Notez la tension artérielle systolique de la femme (TAS) en mmHg.	Alerte: <80, ≥140 <i>Contrôlez la tension artérielle afin de veiller à leur bien-être et d'évaluer les risques de problèmes à la naissance (5). L'hypotension pourrait être un signe de choc hémorragique, de choc septique ou de saignement occulte ou visible. Une tension artérielle systolique de 140 mmHg pourrait être un signe d'hypertension (d'autres évaluations sont nécessaires pour établir un diagnostic) (10, 12).</i>	■ Si la TAS est <80 ou ≥140, prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives locales. ■ Si TAS est ≥80 ou <140, réévaluez la TAS toutes les 4 heures.
TA diastolique		Notez la tension artérielle diastolique de la femme (TAD) en mmHg.	Alerte: ≥90 <i>Une tension artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg pourrait être un signe d'hypertension (d'autres évaluations sont nécessaires pour établir un diagnostic) (10).</i>	■ Si la TAD est ≥90, prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives locales. ■ Si la TAD est <90, réévaluez la TAD toutes les 4 heures.
Température	Mesurez la température axillaire.	Notez la température de la femme en degrés Celsius.	Alerte: <35,0; ≥ 37,5 <i>La température devrait être contrôlée tout au long du travail afin d'évaluer le bien-être de la femme et de repérer les risques de problèmes à la naissance (5).</i>	■ Si la température est <35,0 ou ≥37,5, prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives locales. ■ Si la température se situe entre 35,0 et 37,4 degrés Celsius, réévaluez la température toutes les 4 heures.

Urines	Contrôlez la présence de protéines et d'acétone dans les urines à l'aide d'une bandelette réactive.	Notez les résultats obtenus pour les protéines (P) et l'acétone (A) : négatif, traces, +, ++, +++ et ++++.	Alerte: P++, A++ <i>Si la quantité de protéines est évaluée à 2+ (P++), des mesures complémentaires pourraient être requises, bien que les résultats puissent être confirmés à l'aide d'une deuxième bandelette réactive à la prochaine miction. La protéinurie pourrait être un signe de prééclampsie, d'infection urinaire, d'anémie grave, ou de maladie rénale ou cardiaque non diagnostiquée jusqu'alors. La cétonurie peut être un signe de déshydratation due à une diminution de l'apport liquidien ou à des pertes excessives (vomissements ou diarrhée), à un travail prolongé ou à un diabète jusqu'alors non diagnostiqué (13).</i>	■ Si les niveaux constatés sont P++ ou A++ ou plus, interprétez ces mesures dans le cadre d'un examen clinique complet. Prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives locales. ■ Si P = Négatif, Traces ou +, réévaluez toutes les 4 heures ou chaque fois que la femme urine pendant le travail.
--------	---	--	--	--

Exemple de la façon dont il faut remplir la section 4

Date : 07 juin 2020

Heure : 06 h 00

La fréquence cardiaque de Marie est de 88 bpm, avec une tension artérielle de 120/80 mmHg. Sa température est de 36,5°C.

Elle a uriné peu après son admission et ne présente aucune trace de protéinurie ou d'acétone.

Étant donné que tous les paramètres cliniques de la femme sont normaux, la sage-femme prévoit de les contrôler de nouveau dans 4 heures, sauf indication contraire.

Heure : 10 h 00

La fréquence cardiaque de Marie est de 96 bpm, avec une tension artérielle de 128/84 mmHg. Sa température est de 36,9°C. Elle a de nouveau uriné et ne présente aucune trace de protéinurie ou d'acétone.

La figure 6 montre de quelle façon le Guide de gestion du travail d'accouchement devrait être rempli au moyen des informations ci-dessus. Les observations entourées en rouge répondent aux critères correspondants dans la colonne « Alerte ». Pour les paramètres évalués toutes les 4 heures, laissez les cases vides lorsque l'évaluation n'est pas nécessaire.

Figure 6. Comment remplir la section 4

GUIDE DE GESTION DU TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT DE L'OMS														
Nom		Marie Martin		Parité		2		Début du travail		spontané		Diagnostic de la phase active [Date 07/06/20]		
Rupture de membranes [Date 07/06/20 Heure 5:00]				Facteurs de risque		Antécédents de mort-né, anémie								
Heure		6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	:	:	:	:	:	:	:	:
Nb d'heures		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ALERTE		PREMIERE PHASE ACTIVE										DEUXIEME STADE		
SOINS DE SOUTIEN	Accompagnant(e)	N	N	0	0	0	N							
	Anti douleur	N	N	0	0	0	N							
	Liquides per os	N	0	0	0	R	Y							
	Posture	DD	EM	DD	EM	EM	DD							
BEBE	RCF de Base	<110, ≥160	140	136	132	148	133	145	138	128	151	133		
	Ralentissement du RCF	TD	N	N	V	N	N	N	N	N	V	N		
	Liquide amniotique	M+++ , S	C	C							+			
	Présentation	P, T	P								T			
	Bosse séro sanguine	+++	0								+			
	Modelage de la tête	+++	0								+			
FEMME	Pouls	<60, ≥120	88								96			
	TA systolique	<80, ≥140	120								128			
	TA diastolique	≥90	80								84			
	Température °C	<35,0; ≥ 37,5	36,5								36,9			
	Urines	P++, A++	-/-								-/-			

Comment remplir la section 5 : Progression du travail

Cette section vise à encourager la pratique systématique de la surveillance intermittente des paramètres de progression du travail. La progression du travail est notée dans le Guide de gestion du travail d'accouchement au moyen d'observations régulières de la fréquence et de la durée des contractions, de la dilatation du col et de la descente de la tête du bébé (voir tableau 6).

Tableau 6. Instructions pour remplir la section 5 du Guide de gestion du travail

	Étape 1: Évaluer	Étape 2: Enregistrer	Étape 3: Vérifier les seuils de référence	Étape 4: Planifier
Contractions par 10 min	Comptez le nombre de contractions utérines sur une période de 10 minutes.	Notez le nombre absolu de contractions.	Alerte: ≤ 2, > 5 <i>Si les contractions sont inefficaces, il est possible que l'activité utérine soit inadéquate (9). Les contractions continues sont un signe de dystocie (10).</i>	■ Si les contractions sont ≤ 2 ou > 5 sur une période de 10 minutes, comptez-les de nouveau sur une autre période de 10 minutes. Si la fréquence est confirmée, prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives cliniques. ■ Si les contractions sont de 3 à 5 par période de 10 minutes, réévaluez-les toutes les 30 minutes pendant le premier stade du travail, et au moins toutes les 15 minutes pendant le deuxième stade.
Durée des contractions	Déterminez la durée des contractions.	Notez la durée des contractions en secondes.	Alerte: < 20, > 60 <i>Des contractions courtes pourraient indiquer une activité utérine inadéquate. Plus de 5 contractions en 10 minutes ou des contractions continues sont des signes de dystocie ou d'hyperstimulation (9).</i>	■ Si les contractions durent moins de 20 secondes ou plus de 60 secondes, chronométrez-les de nouveau sur une autre période de 10 minutes. Si la durée est confirmée, prévenez un prestataire de soins plus expérimenté ou plus qualifié et suivez les directives cliniques locales. ■ Si les contractions durent entre 20 et 60 secondes, réévaluez-les toutes les 30 minutes pendant le premier stade du travail et au moins toutes les 15 minutes pendant le deuxième stade du deuxième stade.

Dilatation du col	Effectuez un examen vaginal avec douceur, après avoir obtenu le consentement de la femme et veillé à préserver son intimité. Utilisez une technique aseptique pour examiner le col de l'utérus. Ne commencez pas l'examen pendant une contraction utérine. Évaluez en même temps tous les paramètres qui nécessitent un examen vaginal.	Pendant la phase active du premier stade du travail, mettez « X » dans la case qui correspond à l'heure et au degré de dilatation chaque fois que vous effectuez un examen vaginal. Pendant le deuxième stade, notez « P » pour indiquer quand la poussée commence.	Valeurs d'alerte pour la première phase 5 cm = ≥6 h (la dilatation du col reste à 5 cm pendant 6 heures ou plus) 6 cm = ≥5 h (la dilatation du col reste à 6 cm pendant 5 heures ou plus) 7 cm = ≥3 h (la dilatation du col reste à 7 cm pendant 3 heures ou plus) 8 cm = ≥2 h 30 (la dilatation du col reste à 8 cm pendant 2 h 30 ou plus) 9 cm = ≥2 h (la dilatation du col reste à 9 cm pendant 2 heures ou plus) Valeurs d'alerte pour le deuxième stade ≥3 h chez les femmes nullipares ≥2h chez les femmes multipares (la naissance n'est pas terminée au bout de 3 heures à partir du début du deuxième stade chez les nullipares et 2 heures chez les multipares) <i>Les données disponibles montrent des variations importantes des rythmes de dilatation du col chez les femmes sans risques de complications, beaucoup de femmes progressant plus lentement que 1 cm/heure pendant la majeure partie de leur travail et donnant tout de même naissance par voie vaginale sans issue défavorable (5, 14).</i>	■ L'alerte est déclenchée quand le col reste dilaté au même niveau plus longtemps que la durée maximale prévue. ■ Pendant la première phase, si le travail progresse comme prévu, évaluez la dilatation du col toutes les 4 heures, sauf indication contraire. Lorsque vous effectuez un examen vaginal moins de 4 heures après l'évaluation précédente, assurez-vous que cet examen apporte effectivement des renseignements importants qui contribueront à la prise de décision.
Descente	Évaluez la descente par palpation abdominale ; déterminez quelle partie de la tête (divisée en cinq parties) est palpable au-dessus de la symphyse pubienne.	Notez « O » dans la case qui correspond à l'heure et au niveau de descente. Faites un « O » à chaque examen vaginal. Utilisez les notations 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5 et 0/5 pour décrire l'emplacement du fœtus déterminé par palpation de l'abdomen (9).	Il n'y a pas de seuils de référence pour cette observation, qui variera selon chaque cas.	■ Pendant le premier stade, évaluez la descente toutes les 4 heures avant d'effectuer un examen vaginal, sauf indication contraire. ■ Pendant le deuxième stade, tenez compte du comportement de la femme, de l'efficacité de la poussée et de la position et du bien-être du bébé pour savoir quand évaluer la descente.

Exemple de la façon dont il faut remplir la section 5

Date : 07 juin 2020

Heure : 06 h 00

Au moment de l'admission, Marie avait trois contractions utérines toutes les 10 minutes, d'une intensité modérée et d'une durée de 40 secondes.

L'examen vaginal montre que le col est dilaté à 5 cm, présentation céphalique. La descente fœtale est de 4/5.

Étant donné que tous les autres paramètres cliniques sont normaux et que Marie supporte bien le travail, la sage-femme évalue le nombre et la durée des contractions utérines toutes les demi-heures. Les examens vaginaux sont évités s'ils sont inutiles et ne sont effectués que toutes les 4 heures.

Heure : 10 h 00

Marie se plaint de fortes douleurs. Sa sœur a quitté la maternité et Marie est seule, en position couchée en décubitus dorsal sur le lit. Ses signes vitaux sont les suivants : fréquence cardiaque : 96 bpm ; tension artérielle : 128/84 mmHg ; RCF : 151 bpm avec ralentissements variables. Marie a trois fortes contractions utérines toutes les 10 minutes, d'une durée de 50 secondes. La descente fœtale est de 3/5. La dilatation du col est de 8 cm et le fœtus est en position occipito-transverse. Le liquide amniotique contient du méconium 1+/4).

La sage-femme lui propose un accompagnant de son choix. Marie veut être accompagnée par sa sœur qui était partie parler avec sa famille dans la salle d'attente. La sage-femme donne des instructions à la sœur sur la façon de soutenir Marie et de la réconforter en utilisant un chiffon sur son visage et son corps, et en lui massant le dos.

Heure : 13 h 00

Marie a toujours trois fortes contractions utérines toutes les 10 minutes, d'une durée de 50 secondes. La descente fœtale est de 2/5. Le col est dilaté à 10 cm et le fœtus est en position occipito-antérieure. Le liquide amniotique contient du méconium 1+/4. RCF : 132 bpm, sans ralentissements.

Heure : 13 h 30

Marie a toujours quatre fortes contractions utérines toutes les 10 minutes, d'une durée de 50 secondes. La descente fœtale est de 0/5 RCF : 118 bpm, avec ralentissements précoces.

L'accouchement a lieu par voie vaginale à 13 h 45.

La figure 7 montre de quelle façon le Guide de gestion du travail d'accouchement devrait être rempli au moyen des informations ci-dessus.

Figure 7. Comment remplir la section 5

GUIDE DE GESTION DU TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT DE L'OMS																																	
Nom		Marie Martin		Parité		2		Début du travail		spontané		Diagnostic de la phase active [Date		07/06/20																			
Rupture de membranes [Date		07/06/20		Heure		5:00		Facteurs de risque		Antécédents de mort-né, anémie																							
Heure		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		:		:		:		:		13:05		13:45		:		:	
Nb d'heures		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3			
ALERTE		PREMIERE PHASE ACTIVE																								DEUXIEME STADE							
SOINS DE SOUTIEN	Accompagnant(e)	N	N	0	0	0	0	N	0	0	0																						
	Anti douleur	N	N	0	0	0	0	N	0	0	0																						
	Liquides per os	N	0	0	0	R	0	0	R	0																							
	Posture	DD	EM	DD	EM	EM	DD	EM	EM	DD																							
BEBE	RCF de Base	<110, ≥160	140	136	132	148	133	145	138	128	151	133	149	125	153	130	132																
	Ralentissement du RCF	TD	N	N	V	N	N	N	N	N	V	N	N	N	N	N	N																
	Liquide amniotique	M+++, S	C								+						+																
	Présentation	P, T	P								T						A																
	Bosse séro sanguine	+++	0								+						+																
	Modelage de la tête	+++	0								+						++																
FEMME	Pouls	<60, ≥120	88								96																						
	TA systolique	<80, ≥140	120								128																						
	TA diastolique	≥90	80								84																						
	Température °C	<35,0; ≥37,5	36,5								36,9																						
PROGRESSION DU TRAVAIL	Urines	P++, A++	-/-								-/-																						
	Contractions par 10 min	≤2, >5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3																	
	Durée des contractions	<20, >60	40	40	40	40	40	45	40	45	50	50	50	40	50	50	50																
	Dilatation du col [Noter X]	10															x																
		9 ≥ 2h																															
		8 ≥ 2.5h																															
		7 ≥ 3h																															
		6 ≥ 5h																															
	5 ≥ 6h		x																														
	Descente [Noter O]	5																															
4																																	
3																																	
2																																	
1																																	
0																																	

Pendant la phase active, marquer 'X' pour noter la dilatation du col. L'alerte est déclenchée quand le temps maximum pour la dilatation actuelle est dépassé sans progrès. Au cours du deuxième stade, insérer 'P' pour indiquer que la femme commence à pousser.

Comment remplir la section 6 : Médicaments

Cette section vise à faciliter l'enregistrement systématique de tous les types de médicaments administrés pendant le travail ; il faut y noter si la femme reçoit de l'ocytocine et, si oui, à quelle dose, et si d'autres médicaments ou liquides IV sont administrés (voir tableau 7).

Tableau 7. Indications pour remplir la section 6 du Guide de gestion du travail

	Étape 1: Évaluer	Étape 2: Enregistrer
Ocytocine	De l'ocytocine est-elle actuellement administrée à la femme ?	- Si pas d'ocytocine administrée, notez N = Non. - Si de l'ocytocine est administrée, notez la quantité d'ocytocine en unités par litre (UI) et en gouttes par minute (gouttes/min). - En cas d'administration d'ocytocine, notez la quantité donnée toutes les 60 minutes.
Autres médicaments	D'autres médicaments sont-ils donnés à la femme ?	- Si aucun autre médicament n'est donné, notez N = Non. - Si d'autres médicaments sont donnés, notez le nom, la dose et la voie d'administration de tout médicament supplémentaire donné à la femme au cours du premier stade active ou du deuxième stade du travail [par exemple, 50 mg de péthidine par voie intramusculaire (IM)].

Liquides IV	Des liquides sont-ils administrés à la femme par voie intraveineuse ?	Notez : O = Oui N = Non <i>Une perfusion IV à toutes les femmes qui accouchent n'est pas recommandée, étant donné qu'elle réduit la mobilité des femmes et augmente inutilement les coûts. Les femmes à faible risque devraient être encouragées à ingérer des liquides par voie orale, et elles ne devraient recevoir de perfusion IV que si cela est indiqué (5).</i>
--------------------	---	---

Comment remplir la section 7 : Prise de décision consensuelle

Cette section vise à faciliter la communication constante avec la femme et la personne qui l'accompagne, ainsi que l'enregistrement systématique de toutes les évaluations et des plans de soins convenus (voir le tableau 8).

Tableau 8. Indications pour remplir la section 7 du Guide de gestion du travail

	Enregistrer
Évaluation	■ Prenez note de l'évaluation clinique et toutes les constatations supplémentaires qui n'ont pas été notées auparavant, mais qui sont importantes pour le suivi du travail.
Plan de soins	■ Notez le plan de soins établi à la suite de l'évaluation. Par exemple : • poursuite de la surveillance de routine ; • prescription de tests de diagnostic ; • accélération du travail au moyen d'une perfusion d'ocytocine ; • procédures, telles que la rupture artificielle des membranes ; • accouchement assisté avec ventouse obstétricale ou forceps ; • césarienne. ■ Tenez compte du fait que les femmes doivent participer aux discussions et pouvoir prendre des décisions éclairées. ■ Chaque fois qu'une évaluation clinique du bien-être de la femme et de l'enfant est terminée, notez le plan de soins convenu avec la femme.

Exemple de la façon dont il faut remplir les sections 6 et 7

Le travail et l'accouchement de Marie ont progressé normalement.

Pendant le travail, Marie a été encouragée à marcher et être accompagnée par la personne de son choix.

Les paramètres cliniques sont restés à des niveaux normaux. Par conséquent, aucune intervention supplémentaire n'a été nécessaire.

La figure 8 montre de quelle façon les sections 6 et 7 du Guide de gestion du travail d'accouchement seraient remplies au moyen des informations ci-dessus.

Figure 8. Comment remplir les sections 6 et 7

GUIDE DE GESTION DU TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT DE L'OMS																																	
Nom		Marie Martin		Parité		2		Début du travail		spontané		Diagnostic de la phase active [Date 07/06/20]																					
Rupture de membranes [Date 07/06/20 Heure 5:00]				Facteurs de risque		Antécédents de mort-né, anémie																											
Heure		6:00		7:00		8:00		9:00		10:00		11:00		12:00		13:00		:		:		:		:		13:05		13:45		:			
Nb d'heures		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3			
		ALERTE		PREMIERE PHASE ACTIVE												DEUXIEME STADE																	
SOINS DE SOUTIEN	Accompagnant(e)	N	N	0	0	0	0	N	0	0	0							0								0							
	Anti douleur	N	N	0	0	0	0	N	0	0	0							0								0							
	Liquides per os	N	0	0	0	R	0	0	R	0								0								0							
	Posture	DD	EM	DD	EM	EM	DD	EM	EM	DD								DD								DD							
BEBE	RCF de Base	<110, ≥160	140	136	132	148	133	145	138	128	151	133	149	125	153	130	132										115	128	118				
	Ralentissement du RCF	TD	N	N	V	N	N	N	N	N	V	N	N	N	N	N	N										N	Pr	P				
	Liquide amniotique	M+++ , S	C								+						+																
	Présentation	P, T	P								T						A																
	Bosse séro sanguine	+++	0								+						+																
	Modelage de la tête	+++	0								+						++																
FEMME	Pouls	<60, ≥120	88								96																						
	TA systolique	<80, ≥140	120								128																						
	TA diastolique	≥90	80								84																						
	Température °C	<35,0 ; ≥ 37,5	36,5								36,9																						
Urines	P++ , A++	-/-								-/-																							
PROGRESSION DU TRAVAIL	Contractions par 10 min	≤2, >5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3											3	4	4				
	Durée des contractions	<20, >60	40	40	40	40	45	40	45	50	50	50	40	50	50	50											50	50	50				
	Dilatation du col [Noter X]	10																															
		9	≥ 2h																														
		8	≥ 2.5h																														
		7	≥ 3h																														
		6	≥ 5h																														
	5	≥ 6h	x																														
	Descente [Noter O]	5																															
		4		o																													
3											o																						
2																	o																
1																																	
0																																	
MEDICAMENTS	Ocytocine (U/L, gouttes/min)		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N											N						
	Médicament		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N											N						
	Liquides IV		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N											N						
PRISE DE DECISION PARTAGEE	EVALUATION		SOULAGER LES DOULEURS	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	SOULAGER LES DOULEURS	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL	TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL											TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT NORMAL						
	PLAN DE SOINS		Proposer un accompagnant et techniques de relaxation ; surveillance de routine					Surveillance de routine			Proposer un accompagnant et techniques de relaxation ; surveillance de routine					Surveillance de routine												Surveillance de routine					
INITIALES DU PRESTATIAIRE		LA	LA	LA	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP											GP						

INSTRUCTIONS : ENCERCLER TOUTE OBSERVATION QUI REpond AUX CRITERES DANS LA COLONNE 'ALERTE'. ALERTE LA SAGE FEMME SENIOR OU LE MEDECIN ET NOTER L'EVALUATION FAITE ET L'ACTION DECIDEE. SI LE TRAVAIL SE PROLONGE AU-DELA DE 12H, VEUILLEZ CONTINUER SUR UN NOUVEAU GUIDE DE GESTION DU TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT.

Abbréviations: O – Oui, N – Non, R – Refusé, In – Inconnu, DD – Décubitus Dorsal, EM – En Mouvement, Pr – Précoce, TD – Tardif, V – Variable, I – Intact, C – Clair, M – Méconium, S – Sanguinolent, A – Antérieur, P – Postérieur, T – Transverse, P+ – Protéines, A+ – Acétones

Références bibliographiques

1. Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp O, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. *Lancet Glob Health*. 2014;2(6):e323-33.
2. Lawn JE, Blencowe H, Waiswa P, Amouzou A, Mathers C, Hogan D, et al. Stillbirths: rates, risk factors, and acceleration towards 2030. *Lancet*. 2016;387(10018):587-603.
3. Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division: executive summary. Geneva: World Health Organization; 2019. Contract No.: WHO/RHR/19.23.
4. Bhutta ZA, Das JK, Bahl R, Lawn JE, Salam RA, Paul VK, et al. Can available interventions end preventable deaths in mothers, newborn babies, and stillbirths, and at what cost? *Lancet*. 2014;384(9940):347-70.
5. Recommandations de l'OMS sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l'accouchement. Brazzaville: Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l'Afrique; 2021.
6. Oladapo OT, Diaz V, Bonet M, Abalos E, Thwin SS, Souza H, et al. Cervical dilatation patterns of 'low-risk' women with spontaneous labour and normal perinatal outcomes: a systematic review. *BJOG*. 2018;125(8):944-54.
7. Abalos E, Oladapo OT, Chamillard M, Diaz V, Pasquale J, Bonet M, et al. Duration of spontaneous labour in 'low-risk' women with 'normal' perinatal outcomes: a systematic review. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2018;223:123-32.
8. Oladapo OT, Tunçalp Ö, Bonet M, Lawrie TA, Portela A, Downe S, et al. WHO model of intrapartum care for a positive childbirth experience: transforming care of women and babies for improved health and wellbeing. *BJOG*. 2018 Jul;125(8):918-922
9. Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors, 2nd ed. Geneva: World Health Organization; 2017.
10. WHO, UNFPA, UNICEF. Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: a guide for essential practice, 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2015.
11. Liabsuetrakula T. Algorithm of intrapartum care for abnormal vaginal loss: liquor abnormalities, blood and purulent discharge. *BJOG* 2020. (in press).
12. Haddad SM, Souza RT, Cecatti JG. Pulse and blood pressure: developing algorithms for supporting digital-Health for management of maternal intrapartum complications. *BJOG* 2020. (in press).
13. Cheung KW, Meher S. Clinical algorithm for the management of intrapartum maternal urine abnormalities. *BJOG* 2020. (in press).
14. Zhang J, Landy HJ, Branch DW, Burkman R, Haberman S, Gregory KD, et al. Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes. *Obstet Gynecol*. 2010;116(6):1281-7.
15. Fischer F, Lange K, Klose K, Greiner W, Kraemer A. Barriers and strategies in guideline implementation – a scoping review. *Healthcare (Basel)*. 2016;4(3):36.
16. Vogel JP, Comrie-Thomson L, Pingray V, Gadama L, Galadanci H, Goudar S, et al. Usability, acceptability, and feasibility of the World Health Organization Labour Care Guide: A mixed-methods, multicountry evaluation. *Birth*. 2020 Nov 22.
17. Standards pour l'amélioration de la qualité des soins maternels et néonataux dans les établissements de santé [Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities]. Genève: Organisation mondiale de la Santé ; 2017..

Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS

Nom	Parité	Début du travail	Diagnostic de la phase active [Date
Rupture de membranes [Date	Heure	Facteurs de risque	

INSTRUCTIONS : ENCERCLER TOUTE OBSERVATION QUI REpond AUX CRITERES DANS LA COLONNE 'ALERTE'. ALERter LA SAGE FEMME SENIOR OU LE MEDECIN ET NOTER L'EVALUATION FAITE ET L'ACTION DECIDEE. SI LE TRAVAIL SE PROLONGE AU-DELA DE 12H, VEUILLEZ CONTINUER SUR UN NOUVEAU GUIDE DE GESTION DU TRAVAIL D'ACCOUCHEMENT.

Abbréviations: O – Oui, N – Non, R – Refusé, In – Inconnu, DD – Décubitus Dorsal, EM – En Mouvement, Pr – Précoce, TD – Tardif, V – Viable, I – Intact, C – Clair, M – Méconium, S – Sanguinolent, A – Antérieur, P – Postérieur, T – Transverse, P+ – Protéines, A+ – Acétones

ANNEXE 2

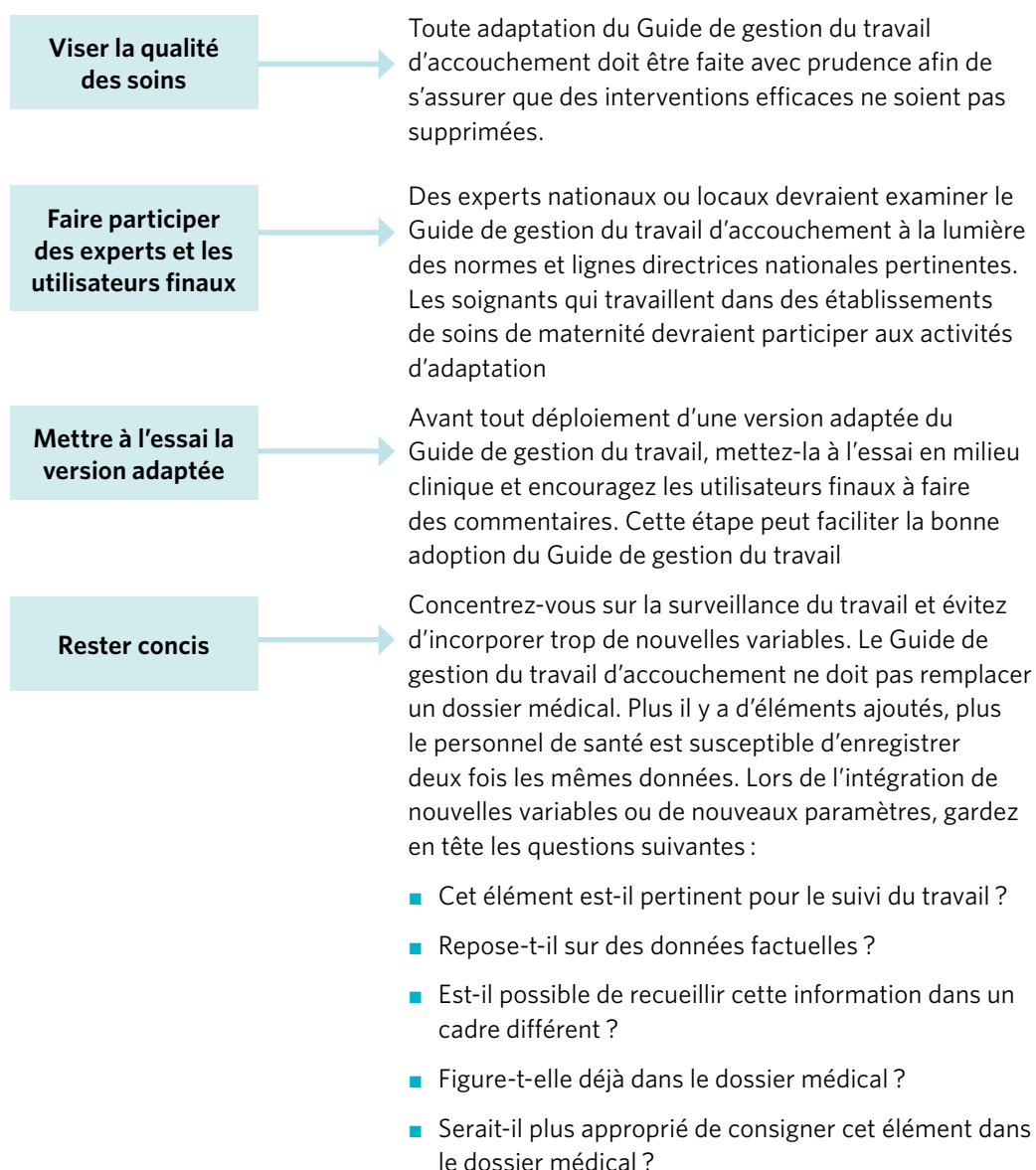
Adaptation du Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS

Le Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS a été élaboré sur la base des *Recommandations de l'OMS sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l'accouchement* (5). Il peut être nécessaire de l'adapter aux conventions locales (par exemple en utilisant les parallèles de Hodge pour évaluer la descente fœtale).

Il est fortement déconseillé de retirer des pratiques recommandées du Guide de gestion du travail. Même dans les milieux où certaines interventions sont moins réalisables ou ne sont pas systématiquement disponibles, il est important de contrôler le recours à ces interventions pour aider à améliorer la qualité globale des soins.

Nous décrivons ci-dessous un processus permettant d'examiner le Guide de gestion du travail d'accouchement et de repérer les éléments à adapter (voir fig. 9).

Figure 9. Processus pour adapter le Guide de gestion du travail d'accouchement



ANNEXE 3

Introduction du Guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS dans les services de maternité

Le Guide de gestion du travail d'accouchement est un outil qui vise à faciliter l'application des *Recommandations de l'OMS sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l'accouchement* (5). Le niveau actuel d'application des différentes pratiques de soins présentées dans le Guide de gestion du travail d'accouchement peut varier. Par exemple, le Guide de gestion du travail d'accouchement comprend des pratiques qui peuvent déjà être bien mises en œuvre dans les services de maternité (comme proposer de l'analgésie pour la douleur). D'autres pratiques ne sont peut-être pas bien appliquées, et le Guide de gestion du travail d'accouchement peut aider les administrateurs et les soignants à se fixer des objectifs pour améliorer la qualité des soins prodigués pendant le travail et l'accouchement.

Il est évident que la simple diffusion de recommandations ne garantira pas leur adoption réussie par les dispensateurs de soins de santé (15). Il peut également y avoir d'autres obstacles à la mise en œuvre du Guide de gestion du travail d'accouchement dans le cadre des soins courants. Par exemple, les soignants travaillant dans des établissements dont la charge de travail est élevée ou dont les ressources sont limitées peuvent considérer que l'utilisation du Guide de gestion du travail d'accouchement prend beaucoup de temps ou est moins faisable. Dans d'autres établissements, ils peuvent ne pas vouloir mettre à jour les pratiques qu'ils appliquent depuis longtemps ou être réticents à adopter le Guide de gestion du travail d'accouchement dans le cadre des soins courants pour d'autres raisons. Dans de telles situations, une stratégie de mise en œuvre solide doit être élaborée pour introduire le Guide de gestion du travail d'accouchement dans les services de maternité.

Pour introduire le Guide de gestion du travail d'accouchement dans les salles d'accouchements, une stratégie active à composantes multiples sera nécessaire. Une étude pilote menée dans six pays a permis de recenser plusieurs stratégies utilisées pour mettre en œuvre le Guide de gestion du travail d'accouchement (16) (voir tableau 9).

Tableau 9. Stratégies de mise en œuvre de gestion du travail

Examen et adaptation	Leadership et formation
✓ Procéder à un examen critique du Guide de gestion du travail d'accouchement et décider si une adaptation locale est nécessaire. ✓ Veiller à ce que les abréviations que les soignants sont tenus d'utiliser dans le Guide de gestion du travail d'accouchement aient du sens pour eux. ✓ Faire participer les responsables et les administrateurs locaux aux activités d'adaptation. ✓ Optimiser le temps des soignants : éviter au maximum tout doublon entre le Guide de gestion du travail d'accouchement et le dossier médical. ✓ Éviter d'ajouter des variables, principalement si elles n'ont pas d'utilité dans le cadre de la gestion du travail et de l'accouchement. ✓ Viser la meilleure qualité de soins possible ; ne pas supprimer de composantes du Guide de gestion du travail d'accouchement simplement parce qu'elles ne peuvent être mises en œuvre. ✓ Examiner les politiques et les procédures connexes nécessaires pour créer un environnement favorable à l'utilisation du Guide de gestion du travail. ✓ Traduire le Guide de gestion du travail, le manuel et d'autres supports pédagogiques si nécessaire.	✓ Constituer une équipe d'experts spécialisés dans les disciplines couvertes par le Guide de gestion du travail d'accouchement (obstétrique, maïeutique, soins infirmiers), afin de proposer une formation. ✓ Demander à des leaders d'opinion et à des figures de proue locales de se familiariser avec le Guide de gestion du travail. ✓ Prévoir une formation initiale, une formation de remise à niveau et des activités continues de soutien et de mentorat. ✓ Inclure une forte composante pratique dans le programme de formation. ✓ Donner du temps au personnel pour acquérir les compétences nécessaires. Au début, les soignants peuvent trouver le Guide de gestion du travail d'accouchement rébarbatif, et auront besoin du temps pour se familiariser avec l'instrument. ✓ Organiser les formations dans la langue locale. ✓ Donner rapidement un feedback structuré aux utilisateurs ayant rempli le Guide de gestion du travail d'accouchement pour les aider à améliorer leurs compétences.
Travail d'équipe pour le remplir	Suivi et évaluation
✓ L'utilisation du Guide de gestion du travail d'accouchement devrait être la responsabilité de toute l'équipe soignante. ✓ Le Guide de gestion du travail d'accouchement facilite la prise de décision objective axée sur les données. Il faut tenir compte du fait que certains membres du personnel qui remplissent le Guide peuvent avoir besoin d'un soutien et d'une supervision supplémentaires. ✓ Cibler la mise en œuvre universelle (au cours de toutes les gardes). Le Guide de gestion du travail peut faciliter la passation des patientes entre les équipes de garde.	✓ Maintenir ou établir un système de suivi fondé sur le Guide de gestion du travail d'accouchement pour suivre les indicateurs de qualité des soins, par exemple la proportion de femmes accompagnées par la personne de leur choix et le taux de césarienne. ✓ Diffuser les indicateurs de qualité des soins pour contribuer à l'amélioration des soins.

ANNEXE 4

Liste récapitulative des recommandations sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l'accouchement

Option de soin	Recommandation	Type de recommandation
Soins durant le travail et l'accouchement		
Soins maternels respectueux	1. Les soins maternels respectueux, qui consistent à assurer à toutes les femmes un accès à des soins de santé dédiés qui préservent leur dignité, leur intimité et leur confidentialité, leur garantissent l'absence de préjudices et de mauvais traitements et leur permettent des choix éclairés et un soutien continu pendant le travail et l'accouchement, sont recommandés.	Recommandée
Communication effective	2. Une communication effective entre les prestataires de soins de maternité et les femmes qui accouchent, au moyen de méthodes simples et culturellement acceptables, est recommandée.	Recommandée
Accompagnement durant le travail et l'accouchement	3. Il est recommandé que les femmes soient accompagnées par une personne de leur choix tout au long du travail et de l'accouchement.	Recommandée
Continuité des soins	4. Des modèles de continuité des soins sous la direction de sages-femmes, dans lesquels une sage-femme connue ou un petit groupe de sages-femmes connu soutient une femme sur l'ensemble du continuum constitué par les périodes prénatale, intrapartum et postnatale sont recommandés pour les femmes enceintes dans les situations où les programmes de maïeutique fonctionnent bien. ^a	Recommandation spécifique au contexte
Premier stade du travail		
Définitions de la phase de latence et de la phase active du premier stade du travail	5. L'utilisation des définitions suivantes des premières phases du travail : phase de latence et phase active, est recommandée pour la pratique. - La phase de latence (du premier stade du travail) est une période qui se caractérise par des contractions utérines douloureuses et des modifications variables du col comprenant un certain degré d'effacement et une progression lente de la dilatation allant jusqu'à 5 cm pour le premier accouchement ainsi que pour les suivants. - La phase active (du premier stade du travail) est une période qui se caractérise par des contractions utérines douloureuses régulières, un degré important d'effacement du col de l'utérus et une dilatation du col de l'utérus plus rapide allant de 5 cm à la dilatation complète pour le premier accouchement ainsi que pour les suivants.	Recommandée
Durée du premier stade du travail	6. Les femmes devraient être informées que la durée standard de la phase de latence n'a pas été établie et peut grandement varier d'une femme à l'autre. Toutefois, la durée de la phase active (de 5 cm de dilatation jusqu'à dilatation complète) ne dépasse généralement pas 12 heures pour les premiers accouchements, et 10 heures pour les accouchements suivants.	Recommandée

^a Recommandation reprise des *Recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive*.

Option de soin	Recommandation	Type de recommandation
Progression du premier stade du travail	7. En cas de début de travail spontané, le seuil de vitesse de dilatation cervicale de 1 cm/heure au cours de la phase active du premier stade du travail (représenté par la ligne d'alerte du partogramme) n'est pas suffisamment précis pour identifier les femmes présentant des risques de dystocie et n'est donc pas recommandé à cette fin.	Non recommandée
	8. Une vitesse de dilatation de 1 cm/heure au minimum au cours de la phase active est peu réaliste et trop rapide pour certaines femmes et n'est donc pas recommandée pour identifier la progression normale du travail. La seule dilatation du col de l'utérus à une vitesse inférieure à 1 cm/heure ne devrait pas être une indication systématique pour une intervention obstétricale.	Non recommandée
	9. Le travail peut ne pas s'accélérer naturellement avant qu'un seuil de dilatation du col de l'utérus de 5 cm ne soit atteint. Par conséquent, l'utilisation d'interventions médicales pour accélérer le travail et l'accouchement (comme l'administration d'ocytocine ou la césarienne) avant ce seuil n'est pas recommandée lorsque l'état de la mère et celui du fœtus sont rassurants.	Non recommandée
Politique d'admission en salle de travail	10. Pour les femmes enceintes en bonne santé chez qui le travail s'est déclenché spontanément, une politique d'attente du début de la phase active du premier stade de travail pour l'admission en salle de travail est recommandée uniquement dans un contexte de recherche rigoureuse.	Recommandation spécifique au contexte (recherche)
Examen clinique du bassin à l'admission	11. L'examen clinique du bassin à l'admission pour la prise en charge du travail n'est pas recommandé chez les femmes enceintes en bonne santé.	Non recommandée
Examen de routine du bien-être du fœtus lors de l'admission pour la prise en charge du travail	12. La cardiotocographie systématique n'est pas recommandée pour évaluer le bien-être du fœtus lors de l'admission pour la prise en charge du travail des femmes enceintes en bonne santé chez qui le travail s'est déclenché spontanément.	Non recommandée
	13. L'auscultation à l'aide d'un appareil à ultrasons Doppler ou d'un stéthoscope fœtal de Pinard est recommandée pour évaluer le bien-être du fœtus lors de l'admission pour la prise en charge du travail.	Recommandée
Rasage du périnée/du pubis	14. Le rasage systématique du périnée/du pubis n'est pas recommandé avant un accouchement par voie basse. ^a	Non recommandée
Lavement à l'admission	15. L'administration d'un lavement pour réduire le recours à l'accélération du travail n'est pas recommandée. ^b	Non recommandée
Toucher vaginal	16. Un toucher vaginal toutes les quatre heures est recommandé pour l'évaluation systématique de la progression de la phase active du premier stade du travail chez les femmes à faible risque obstétrical. ^a	Recommandée
Cardiotocographie continue pendant le travail	17. La cardiotocographie continue n'est pas recommandée pour évaluer le bien-être du fœtus chez les femmes enceintes en bonne santé chez qui le travail s'est déclenché spontanément.	Non recommandée
Auscultation intermittente du rythme cardiaque fœtal pendant le travail	18. L'auscultation intermittente du rythme cardiaque fœtal avec un appareil à ultrasons Doppler ou un stéthoscope fœtal de Pinard est recommandée chez les femmes enceintes en bonne santé pendant le travail.	Recommandée

^a Recommandation reprise des *Recommandations de l'OMS pour la prévention et le traitement des infections maternelles du péripartum*.

^b Recommandation reprise des *Recommandations de l'OMS relatives à l'accélération du travail*.

Option de soin	Recommandation	Type de recommandation
Analgésie péridurale pour le soulagement de la douleur	19. L'analgésie péridurale est recommandée pour les femmes enceintes en bonne santé demandant un soulagement de la douleur pendant le travail, selon les préférences de la femme.	Recommandée
Opiacés pour le soulagement de la douleur	20. Des opiacés parentéraux, comme le fentanyl, la diamorphine ou la péthidine, sont des options recommandées pour les femmes enceintes en bonne santé demandant un soulagement de la douleur pendant le travail, selon les préférences de la femme.	Recommandée
Techniques de relaxation pour la gestion de la douleur	21. Les techniques de relaxation, incluant la relaxation musculaire progressive, la respiration, la musique, la pleine conscience et d'autres techniques, sont recommandées pour les femmes enceintes en bonne santé demandant un soulagement de la douleur pendant le travail, selon les préférences de la femme.	Recommandée
Techniques manuelles pour la gestion de la douleur	22. Les techniques manuelles, comme le massage ou l'application de compresses ou patchs tièdes, sont des options recommandées pour les femmes enceintes en bonne santé demandant un soulagement de la douleur pendant le travail, selon les préférences de la femme.	Recommandée
Soulagement de la douleur pour prévenir la prolongation du travail	23. Le soulagement de la douleur pour prévenir la prolongation du travail et réduire le recours à l'accélération du travail n'est pas recommandé. ^a	Non recommandée
Liquides et nourriture par voie orale	24. Chez les femmes à faible risque obstétrical, la prise de liquide et de nourriture par voie orale pendant le travail est recommandée. ^a	Recommandée
Mobilité et position maternelle	25. Il est recommandé d'encourager la mobilité et une position verticale pendant le travail chez les femmes à faible risque obstétrical. ^a	Recommandée
Toilette vaginale	26. La toilette vaginale systématique à la chlorhexidine pendant le travail n'est pas recommandée pour prévenir le risque infectieux. ^b	Non recommandée
Prise en charge active du travail	27. Un paquet de soins pour la prise en charge active du travail en prévention d'un travail prolongé n'est pas recommandé.	Non recommandée
Rupture artificielle des membranes systématique	28. Le recours à la rupture artificielle des membranes seule pour prévenir la prolongation du travail n'est pas recommandé. ^a	Non recommandée
Rupture artificielle des membranes et ocytocine précoces	29. Le recours à la rupture artificielle des membranes précoce associée à une accélération précoce du travail par ocytocine pour prévenir le travail prolongé n'est pas recommandé. ^a	Non recommandée
Ocytocine pour les femmes sous analgésie péridurale	30. L'utilisation de l'ocytocine en prévention de la prolongation du travail chez les femmes bénéficiant d'une analgésie péridurale n'est pas recommandée. ^a	Non recommandée
Antispasmodiques	31. L'utilisation d'antispasmodiques pour prévenir le travail prolongé n'est pas recommandée. ^a	Non recommandée
Liquides intraveineux en prévention de la prolongation du travail	32. L'administration de liquides intraveineux en vue de raccourcir la durée du travail n'est pas recommandée. ^a	Non recommandée

^a Recommandation reprise des Recommandations de l'OMS relatives à l'accélération du travail.

^b Recommandation reprise des Recommandations de l'OMS pour la prévention et le traitement des infections maternelles du péricaput.

Option de soin	Recommandation	Type de recommandation
Deuxième stade du travail		
Définition et durée du deuxième stade du travail	33. L'utilisation de la définition et de la durée suivantes du deuxième stade du travail est recommandée pour la pratique. - Le deuxième stade du travail correspond à la période allant de la dilatation complète du col à la naissance du bébé, pendant laquelle la femme ressent une envie involontaire de pousser, provoquée par des contractions utérines d'expulsion. - Les femmes devraient être informées que la durée du deuxième stade du travail varie d'une femme à l'autre. La naissance survient généralement au bout de trois heures pour un premier accouchement alors que pour les accouchements ultérieurs, la naissance intervient dans une limite de temps de deux heures.	Recommandée
Position d'accouchement (pour les femmes n'ayant pas reçu d'analgésie péridurale)	34. Pour les femmes n'ayant pas reçu d'analgésie péridurale, il est recommandé d'encourager l'adoption des positions d'accouchement de leur choix, y compris les positions verticales.	Recommandée
Position d'accouchement (pour les femmes sous analgésie péridurale)	35. Pour les femmes sous analgésie péridurale, il est recommandé d'encourager l'adoption des positions d'accouchement de leur choix, y compris les positions verticales.	Recommandée
Méthode de poussée	36. Les femmes qui se trouvent en phase d'expulsion du deuxième stade du travail doivent être encouragées et aidées à suivre leur envie de pousser.	Recommandée
Méthode de poussée (pour les femmes sous analgésie péridurale)	37. Pour les femmes sous analgésie péridurale au cours du deuxième stade du travail, il est recommandé de retarder la poussée pendant une ou deux heures après la dilatation complète ou jusqu'à ce que la femme retrouve le besoin de pousser dans un contexte où les ressources sont disponibles pour une durée prolongée du deuxième stade et où l'hypoxie périnatale peut être correctement évaluée et gérée.	Recommandation spécifique au contexte
Techniques de prévention des traumatismes périnéaux	38. Pour les femmes dans le deuxième stade du travail, les techniques visant à réduire le traumatisme du périnée et à faciliter l'accouchement spontané (y compris le massage du périnée, les compresses chaudes, et une surveillance « manuelle » du périnée) sont recommandées, selon les préférences de la femme et les options disponibles.	Recommandée
Indication de l'épisiotomie	39. L'épisiotomie systématique ou sa large utilisation n'est pas recommandée chez les femmes qui accouchent spontanément par voie basse.	Non recommandée
Expression abdominale	40. L'expression abdominale pour faciliter l'accouchement pendant le deuxième stade du travail n'est pas recommandée.	Non recommandée

Option de soin	Recommandation	Type de recommandation
Troisième stade du travail		
Utérotoniques prophylactiques	41. L'utilisation d'utérotoniques en prévention de l'hémorragie du post-partum durant le troisième stade du travail est recommandée pour tous les accouchements.^a 42. L'ocytocine (10 UI, IV/IM) est l'utérotonique recommandé en prévention de l'hémorragie du post-partum.^a 43. Dans les contextes où l'ocytocine n'est pas disponible, l'utilisation d'autres utérotoniques injectables (l'ergométrine/la méthylergométrine ou l'association d'ocytocine et d'ergométrine ou du misoprostol oral (600 µg) est recommandée.	Recommandée Recommandée Recommandée
Clampage tardif du cordon ombilical	44. Le clampage tardif du cordon ombilical (pas avant la 1ère minute après la naissance) est recommandé pour une meilleure santé de la mère et du nourrisson ainsi que pour des raisons nutritionnelles. ^b	Recommandée
Traction contrôlée du cordon ombilical (TCC)	45. Dans les contextes où du personnel qualifié pour les accouchements est disponibles, la traction contrôlée du cordon (TCC) est recommandée pour les naissances si le prestataire de santé et la parturiente prennent en considération l'importance d'une légère diminution de la perte de sang et d'une légère diminution de la durée du troisième stade du travail. ^a	Recommandée
Massage utérin	46. Le massage utérin soutenu n'est pas recommandé en tant qu'intervention visant à empêcher l'hémorragie post partum (HPP) chez les femmes ayant reçu de l'ocytocine prophylactique. ^a	Non recommandée
Soins du nouveau-né		
Aspiration systématique de la bouche et du nez	47. Pour les nouveau-nés dont le liquide amniotique est clair et qui respirent spontanément après la naissance, l'aspiration de la bouche et du nez ne devrait pas être réalisée. ^c	Non recommandée
Contact peau-à-peau	48. Les nouveau-nés sans complications devraient être gardés en contact peau-à-peau avec leur mère pendant la première heure après la naissance afin de prévenir l'hypothermie et d'encourager l'allaitement maternel. ^d	Recommandée
Allaitement maternel	49. Tous les nouveau-nés, y compris les enfants à faible poids de naissance qui sont capables de prendre le sein, devraient être mis au sein le plus rapidement possible après la naissance dès qu'ils sont cliniquement stables, et que la mère et l'enfant sont prêts. ^e	Recommandée
Prophylaxie de la maladies hémorragique par vitamine K	50. Tous les nouveau-nés devraient recevoir 1 mg de vitamine K par voie intramusculaire après la naissance (c'est à dire après la première heure durant laquelle l'enfant devrait être en contact peau-à-peau avec sa mère et l'allaitement maternel devrait être initié). ^d	Recommandée

^a Recommandation reprise des *Recommandations de l'OMS pour la prévention et le traitement de l'hémorragie du post-partum*.

^b Recommandation reprise des recommandations de l'OMS relatives au clampage tardif du cordon pour l'amélioration des issues sanitaires et nutritionnelles maternelles et néonatales, disponibles en anglais [*WHO Guideline: delayed cord clamping for improved maternal and infant health and nutrition outcomes*].

^c Recommandation reprise des recommandations de l'OMS relatives aux premiers soins de réanimation du nouveau-né, disponibles en anglais [*WHO Guidelines on basic newborn resuscitation*].

^d Recommandation reprise des recommandations de l'OMS relatives à la prise en charge des affections courantes de l'enfance : éléments factuels pour l'actualisation technique du mémento, disponibles en anglais [*WHO Recommendations for management of common childhood conditions: evidence for technical update of pocket book recommendations*].

^e Recommandation reprise des recommandations de l'OMS relatives à la santé du nouveau-né, disponibles en anglais [*Integrated from WHO recommendations on newborn health*].

Option de soin	Recommandation	Type de recommandation
Soins du nouveau-né		
Bain et autres soins postnatals immédiats du nouveau-né.	51. Le bain devrait être reporté au moins 24 heures après la naissance. Si cela n'est pas possible pour des raisons culturelles, le bain devrait être reporté au moins six heures. Il est recommandé de vêtir l'enfant correctement en fonction de la température ambiante. Cela signifie une ou deux couches de vêtements de plus que les adultes, ainsi que des bonnets/capuchons. La mère et l'enfant ne devraient pas être séparés et devraient rester dans la même pièce 24 heures sur 24.	Recommandée
Soins de la femme après l'accouchement		
Surveillance de la tonicité utérine	52. La surveillance de la tonicité utérine dans le post-partum pour l'identification précoce de l'atonie utérine est recommandée pour toutes les femmes. ^b	Recommandée
Antibiotiques en cas d'accouchement par voie basse sans complications	53. L'antibiothérapie prophylactique systématique n'est pas recommandée chez les femmes ayant eu un accouchement par voie basse sans complications. ^c	Non recommandée
Antibiothérapie prophylactique systématique en cas d'épisiotomie	54. L'antibiothérapie prophylactique systématique n'est pas recommandée chez les femmes ayant eu une épisiotomie. ^c	Non recommandée
Surveillance maternelle postpartum de routine	55. Toutes les femmes dans le post-partum devraient avoir un examen régulier systématique du saignement vaginal, des contractions utérines, de la hauteur utérine, de la température et de la fréquence cardiaque pendant les premières 24 heures à compter de la première heure après la naissance. La tension artérielle devrait être mesurée rapidement après la naissance. Si elle est normale, une deuxième mesure devrait être effectuée dans les six heures. La diurèse devrait être vérifiée dans les six heures. ^a	Recommandée
Sortie de l'hôpital après un accouchement par voie basse sans complications	56. Après une naissance sans complications dans un établissement de santé, les mères en bonne santé et leur nouveau-né devraient recevoir des soins dans l'établissement pendant au moins 24 heures après la naissance. ^{a,d}	Recommandée

^a Recommandation reprise des recommandations de l'OMS relatives aux soins postnatals de la mère et du nouveau-né, disponibles en anglais [WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn].

^b Recommandation reprise des *Recommandations de l'OMS pour la prévention et le traitement de l'hémorragie du post-partum*.

^c Recommandation reprise des *Recommandations de l'OMS pour la prévention et le traitement des infections maternelles du péripartum*.

^d Pour le nouveau-né, la prise en charge inclut une évaluation immédiate à la naissance, un examen clinique complet environ une heure après la naissance et un autre examen avant la sortie.

ANNEXE 5

Matériel et fournitures de base pour les soins intrapartum

L'établissement de santé doit disposer, en quantité suffisante et à tout moment, du matériel et des fournitures de base essentiels pour les soins courants et la détection des complications dans les unités de maternité réservées au travail et à l'accouchement (17).

Les informations énumérées dans la présente section ne sont ni censées constituer une liste exhaustive, ni laisser entendre que, par omission, d'autres équipements et fournitures peuvent ne pas être nécessaires pour fournir des soins intrapartum de qualité, en fonction de la disponibilité des ressources et des préférences des femmes et des soignants.

Chambre chaude et propre ■ Tables d'examen ou lits avec des draps propres en quantité suffisante ■ Source de lumière ■ Appareil de chauffage ■ Toilette/Salle de bain propre et accessible aux femmes qui accouchent ■ Rideaux s'il y a plus d'un lit dans la pièce	Matériel ■ Sphygmomanomètre ou autre machine servant à mesurer la tension artérielle ■ Stéthoscope ■ Thermomètre ■ Stéthoscope fœtal ou Doppler
Hygiène des mains ■ Approvisionnement en eau propre ■ Savon ■ Brosse ou bâtonnet pour nettoyer les ongles ■ Serviettes propres ■ Solution hydroalcoolique pour l'hygiène des mains	Médicaments ■ Solutés ■ Ocytocine ■ Sulfate de magnésium injectable ■ Antibiotiques ■ Médicaments antirétroviraux ■ Antihypertenseurs ■ Analgésiques ■ Anesthésiques
Gestion des déchets ■ Corbeille pour les serviettes et les tampons d'alcool souillés ■ Réceptacle pour le linge souillé ■ Récipient pour les déchets tranchants	Stérilisation ■ Stérilisateur pour instruments ■ Pot pour les pinces ■ Ventouse
Divers ■ Copies imprimées du guide du gestion du travail ■ Horloge murale ■ Lampe torche avec piles et ampoule de rechange ■ Registre ■ Dossiers médicaux ■ Formulaires de consentement éclairé ■ Réfrigérateur ■ Installations de base pour les accompagnants (chaise, espace où se changer, vêtements, accès aux toilettes) ■ Espace privé pour la femme et l'accompagnante ■ Alimentation électrique ■ Nourriture et eau potable	Consommables médicaux ■ Gants ■ Sonde urinaire ■ Seringues et aiguilles ■ Lame/ciseaux stérilisés ■ Tubulure pour perfusions intraveineuses ■ Cathéters veineux ■ Matériel de suture pour la réparation en cas de déchirure ou d'épisiotomie ■ Solution antiseptique (iodophores ou chlorhexidine) ■ Solution alcoolique (à 70%) ■ Coton pour tampons d'alcool ■ Désinfectant (à base de chlore) ■ Moustiquaire imprégnée d'insecticide ■ Bandelette réactives pour urine ■ Pinces ■ Bouteilles/concentrateur d'oxygène

Pour plus d'informations, contacter :

Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia 20, CH-1211 Genève 27, Suisse

Département Santé sexuelle et reproductive
Courriel : srhmph@who.int.

